Тема № 1

Топография и операции на голове и шее

1. В каком направлении следует производить рассечение мягких тканей при первичной хирургической обработке раны лобно-теменно-затылочной области?

а) в продольном;

б) в поперечном;

в) **в радиальном относительно верхней точки головы;**

г) рана рассекается крестообразно.

2. Какую форму необходимо придать ране при первичной хирургической обработке мягких тканей лобно-теменно-затылочной области?

а) округлую;

б) веретенообразную;

в) Z-образную;

г) подковообразную.

3. Какие ткани входят в состав скальпа?

а) кожа и подкожная клетчатка;

б) кожа, подкожная клетчатка и сухожильный шлем;

в) все мягкие ткани, включая надкостницу;

г) мягкие ткани лобно-теменно-затылочной области и отломки костей свода черепа.

4. Чем характеризуется гематома подкожной клетчатки лобно-теменно-затылочной области?

а) имеет форму шишки;

б) распространяется в пределах одной кости;

в) имеет разлитой характер и свободно перемещается в пределах лобно-теменно-затылочной области;

г) свободно распространяется на подкожную клетчатку височной области и лица.

5. Чем характеризуется поднадкостничная гематома лобно-

теменно-затылочной области?

а) имеет форму шишки;

б) распространяется в пределах одной кости;

в) имеет разлитой характер и свободно перемещается в пределах лобно-теменно-затылочной области;

г) свободно распространяется на клетчатку лица.

6. Чем характеризуется подапоневротическая гематома лобно-теменно-затылочной области?

а) имеет пульсирующий характер;

б) имеет форму овала, ориентированного в продольном направлении;

в) свободно перемещается в пределах лобно-теменно-затылочной области;

г) четкую характеристику дать невозможно.

7. Как следует поступать при первичной хирургической обработке лобно-теменно-затылочной области, обнаружив в ране крупный костный осколок, связанный надкостницей с костями свода черепа?

а) такой осколок следует удалить;

б) такой осколок следует сохранить;

в) при проникающем ранении головы осколок сохраняют;

г) при непроникающем ранении головы осколок сохраняют.

8. Из какого количества слоев состоят кости свода черепа?

а) из одного;

б) из двух;

в) из трех;

г) из четырех.

9. Какие способы используют для временной остановки кровотечения из сосудов мягких тканей лобно-теменно-затылочной области?

а) пальцевое прижатие сосудов по окружности раны;

б) использование кровоостанавливающих зажимов с заостренными концами;

в) использование штифтов;

г) замазывание просвета сосудов восковой пастой.

10. Какие способы используют для остановки кровотечения из сосудов губчатого вещества костей свода черепа?

а) пальцевое прижатие наружной костной пластинки;

б) использование специальных кровоостанавливающих зажимов;

в) тампонада раны кетгутом;

г) втирание восковой пасты в поперечный срез кости.

11. Какие ранения головы называются проникающими?

а) связанные с повреждением костей свода черепа;

б) связанные с повреждением вещества мозга;

в) связанные с повреждением твердой мозговой оболочки;

г) связанные с повреждением мягкой мозговой оболочки.

12. Какие слои костей свода черепа более склонны к повреждению при травме черепа?

а) все слои;

б) наружная пластинка;

в) внутренняя пластинка;

г) губчатое вещество.

13. Как называется трепанация, при которой удаляется фрагмент кости?

а) костно-пластическая;

б) декомпрессионная;

в) ламинэктомия;

г) одномоментная.

14. Ветвью какой артерии является средняя менингеальная артерия?

а) внутренней сонной артерии;

б) верхнечелюстной артерии;

в) лицевой артерии;

г) затылочной артерии.

15. В какой точке проецируется основной ствол средней оболочечной артерии при использовании схемы Кренлейна — Брюсовой?

а) на пересечении передней вертикали и верхней горизонтали;

б) на пересечении передней вертикали и нижней горизонтали;

в) на пересечении задней вертикали и верхней горизонтали;

г) на пересечении средней вертикали и верхней горизонтали.

16. Какими инструментами следует пользоваться для выделения костного лоскута при костно-пластической трепанации?

а) пила дуговая;

б) пила листовая;

в) проволочная пила (Джигли);

г) кусачки Дальгрена.

17. Как проводится проекционная линия выводного протока околоушной слюнной железы?

а) по середине тела нижней челюсти;

б) от основания козелка уха до угла рта;

в) от наружного слухового прохода до середины расстояния от крыла носа до угла рта;

г) от основания козелка уха к крылу носа.

18. Где находится точка пальцевого прижатия лицевой артерии?

а) на 1 см ниже козелка уха;

б) на 0,5-1 см ниже середины нижнего края глазницы;

в) позади угла нижней челюсти;

г) на середине тела нижней челюсти у переднего края жевательной мышцы.

19. Сколько фасций на шее выделяют по классификации, предложенной В. Н. Шевкуненко?

а) одна;

б) две;

в) три;

г) пять.

20. Какая фасция делит шею анатомически на передний и задний отделы?

а) первая;

б) вторая;

в) третья;

г) четвертая.

21. Где проецируется место выхода поверхностных нервов шеи?

а) на уровне верхнего края щитовидного хряща;

б) на уровне подъязычной кости;

в) на середине заднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы;

г) концентрированной точки выхода поверхностных нервов шеи нет.

22. Что относится к особенностям 4-й фасции шеи?

а) наличие париетального и висцерального листков;

б) образование влагалищ сосудисто-нервных пучков;

в) образование фасциальных футляров органов шеи;

г) формирование футляров для глубоких мышц шеи.

23. Между какими фасциями находится надгрудинное клетчаточное пространство?

а) между 1-й и 2-й;

б) между 2-й и 3-й;

в) между 3-й и 4-й;

г) между 2-й и 5-й.

24. В каком клетчаточном пространстве находится непарное венозное сплетение щитовидной железы?

а) в надгрудинном;

б) в превисцеральном;

в) в ретровисцеральном;

г) в предпозвоночном.

25. Какие клетчаточные пространства шеи сообщаются с передним средостением?

а) надгрудинное межапоневротическое;

б) превисцеральное;

в) ретровисцеральное;

г) предпозвоночное.

26. Какие фасции есть в лопаточно-трапециевидном треугольнике?

а) все фасции шеи;

б) 2-я и 5-я;

в) 1-я, 2-я и 5-я;

г) 1-я, 2-я, 3-я.

27. Какие фасции необходимо рассечь при доступе к наружной сонной артерии в сонном треугольнике шеи?

а) 1-ю, 2-ю и 5-ю;

б) 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю;

в) 1-ю, 2-ю и 4 ю;

г) 1-ю, 3-ю и 4-ю.

28. Какие фасции необходимо рассечь в лопаточно-трахеальном треугольнике при проведении трахеостомии?

а) все пять фасций;

б) все фасции кроме 5-й;

в) 1-ю и 2-ю;

г) 1-ю, 2-ю и 4-ю.

29. Какие элементы образуют основной сосудисто-нервный пучок медиального треугольника шеи?

а) общая сонная артерия;

б) внутренняя яремная вена;

в) блуждающий нерв;

г) диафрагмальный нерв.

30. Где проецируется верхняя точка проекционной линии общей сонной артерии?

а) вершина сосцевидного отростка;

б) угол нижней челюсти;

в) середина расстояния между углом нижней челюсти и верхушкой

сосцевидного отростка;

г) середина тела нижней челюсти.

31. Где находится нижняя точка проекционной линии общей сонной артерии?

а) на середине рукоятки грудины;

б) на границе медиальной и средней третей длины ключицы;

в) грудино-ключичный сустав;

г) место прикрепления к грудине II ребра.

32. На каком уровне чаще всего располагается бифуркация общей сонной артерии?

а) на уровне угла нижней челюсти;

б) на уровне верхнего края щитовидного хряща;

в) на уровне подъязычной кости;

г) на уровне середины щитовидного хряща.

33. По каким признакам отличают в операционной ране наружную сонную артерию от внутренней?

а) по наличию отходящих ветвей;

б) по отсутствию боковых ветвей;

в) по медиальному расположению;

г) по латеральному расположению.

34. Ветвью какой артерии является язычная артерия?

а) наружной сонной артерии;

б) внутренней сонной артерии;

в) лицевой артерии;

г) верхней щитовидной артерии.

35. Для обнажения какой артерии в качестве ориентира используется треугольник Пирогова?

а) наружной сонной артерии;

б) внутренней сонной артерии;

в) общей сонной артерии;

г) язычной артерии.

36. Куда чаще впадает грудной проток?

а) в венозный угол Пирогова слева;

б) в венозный угол Пирогова справа;

в) двустороннее впадение в венозный угол Пирогова;

г) грудной проток не имеет постоянного места впадения.

37. Сколько отделов с характерной топографией выделяют на протяжении подключичной артерии на шее?

а) один;

б) два;

в) три;

г) четыре.

38. В какое положение должен быть уложен больной для выполнения трахеостомии?

а) на спине: голова запрокинута кзади, под лопатки подложен валик;

б) на спине: голова повернута влево, под лопатки подложен валик;

в) на спине, голова повернута влево, правая рука оттянута вниз;

г) полусидячее положение с запрокинутой кзади головой.

39. По отношению к какому анатомическому образованию различают верхнюю, среднюю и нижнюю трахеостомии?

а) по отношению к перстневидному хрящу;

б) по отношению к щитовидному хрящу;

в) по отношению к подъязычной кости;

г) по отношению к перешейку щитовидной железы.

40. Какие анатомические ориентиры должны быть совмещены в области шеи при проведении разреза при трахеостомии точно по средней линии?

а) верхняя вырезка щитовидного хряща;

б) середина тела подъязычной кости;

в) середина подбородка;

г) середина яремной вырезки грудины.

41. Что такое эндартерэктомия?

а) удаление небольшого участка артерии;

б) удаление тромба из артерии;

в) удаление атеросклеротической бляшки вместе с участком интимы;

г) удаление большого участка артерии.

42. Выберите область, в которой сухожильный шлем значительно истончается:

а) лобная область;

б) височная область;

в) затылочная область;

г) теменная область.

43. Выберите утверждение, справедливое для субпериостальных абсцессов:

а) имеют разлитой характер;

б) поражают послойно данную область;

в) имеют разлитой характер в пределах нескольких областей;

г) ограничены в пределах одной кости.

44. Назовите ветви внутренней сонной артерии, кровоснабжающие лобную область:

а) надблоковая артерия;

б) глазная артерия;

в) верхнечелюстная артерия;

г) надглазничная артерия.

45. Назовите артерии, кровоснабжающие затылочную область:

а) восходящая глоточная артерия;

б) задняя ушная артерия;

в) затылочная артерия;

г) задняя височная артерия.

46. Ветвью чего является задний ушной нерв?

а) тройничного нерва;

б) лицевого нерва;

в) блокового нерва;

г) глазодвигательного нерва.

47. Какие мышцы вплетаются в надкостницу сосцевидного отростка?

а) грудино-ключично-сосцевидная мышца;

б) заднее брюшко двубрюшной мышцы;

в) длиннейшая мышца головы;

г) ременные мышцы головы и шеи.

48. Какие образования прилежат к передней и задней сторонам треугольника Шипо?

а) канал лицевого нерва;

б) сигмовидный синус;

в) внутренняя сонная артерия;

г) внутренняя яремная вена.

49. Что проходит через овальное отверстие?

а) верхнечелюстной нерв (п. maxillaris);

б) менингеальная добавочная ветвь средней менингеальной артерии (a. meningea accessorius);

в) нижнечелюстной нерв (n. mandibularis);

г) добавочный нерв (п. accessorius).

50. Куда осуществляется венозный отток из пещеристого синуса (sinus cavernosus)?

а) в верхний (sinus petrosus superior) и нижний (sinus petrosus inferior) каменистые синусы;

б) в поперечный синус (sinus transversus);

в) в венозное сплетение овального отверстия (plexus venosus foraminis ovalis);

г) в венозное сплетение сонного канала (plexus venosus caroticus internus).

51. Куда впадает большая мозговая вена (v. cerebri magna)?

а) в сагиттальный синус (sinus sagittalis);

б) в синусы основания черепа;

в) в прямой синус (sinus rectus);

г) в поперечный синус (sinus transversus).

52. Откуда берёт начало лицевая артерия?

а) от наружной сонной артерии (a. carotis externa);

б) от внутренней сонной артерии (a. carotis interna);

в) от базилярной артерии (a. basilaris);

г) от общей сонной артерии (a. carotis communis).

53. С чем анастомозирует угловая артерия (a. angularis)?

а) с глазной артерией (a. Ophthalmica);

б) с дорсальной артерией носа (a. dorsalis nasi);

в) с ветвями околоушной железы (rr. parotidea);

г) с задней ушной артерией (a. auricularis posterior).

54. Что проходит через отверстие нижней челюсти (foramen mandibulae)?

а) подбородочная артерия (a. mentalis);

б) нижняя альвеолярная артерия (a. alveolaris inferior);

в) верхняя альвеолярная артерия (a. alveolaris superior);

г) нижняя губная артерия (a. labialis inferior).

55. Куда могут распространяться гнойные процессы верхней половины лица?

а) в пещеристый синус (sinus cavemosus);

б) в верхний сагиттальный синус (sinus sagittalis superior);

в) в поперечный синус (sinus transversus);

г) в глубокую область лица.

56. Куда может проникнуть ретроградным путём инфекция от подглазничной области при тромбозе лицевой вены?

а) в сигмовидный синус (sinus sigmoideus);

б) в наружную яремную вену (v. jugularis extema);

в) в пещеристый синус (sinus cavemosus);

г) в поверхностную височную вену.

57. Чем в основном осуществляется чувствительная иннервация

кожи лица?

а) лицевым нервом (п. facialis);

б) тройничным нервом (п. trigeminus);

в) языкоглоточным нервом (п. glossopnaryngeus);

г) большим ушным нервом (n. auricularis magnus).

58. Через что выходит лицевой нерв (п. facialis) из полости черепа?

а) через круглое отверстие (foramen rotundum);

б) через остистое отверстие (foramen spinosum);

в) через овальное отверстие (foramen avale);

г) через шилососцевидное отверстие (foramen styiomastoideum).

59. Назовите конечные ветви околоушного сплетения (plexus parotideus) лицевого нерва:

а) височные ветви (rr. temporales);

б) скуловые ветви (rr. zigomatici);

в) шейная ветвь (r. colli);

г) краевая ветвь нижней челюсти (r. marginalis mandibulae).

60. Где расположен язычный нерв (n. lingualis)?

а) в межкрыловидном пространстве (spatium interpterygoideum);

б) в височно-крыловидном пространстве (spatium temporopterygoideum);

в) под слизистой оболочкой дна полости рта;

г) под слизистой оболочкой корня языка.

61. Через что глазница сообщается с полостью черепа?

а) через верхнюю глазничную шель (fissura orbitalis superior);

б) через нижнюю глазничную щель (fissura orbitalis inferior);

в) через зрительный канал (canalis opticus);

г) через клиновидную пазуху (sinus sphenoidalis).

62. Куда впадает верхняя глазная вена (v. ophthalmica superior)?

а) в крыловидное венозное сплетение (plexus venosus pterygoideus);

б) во внутреннюю яремную вену (v. jugularis interna);

в) в пещеристый синус (sinus cavernosus);

г) в верхний сагиттальный синус (sinus sagitalis superior).

63. Куда отводится лимфа от губ?

а) в поднижнечелюстные лимфатические узлы (nodi lymphatici submandibulares);

б) в щечные лимфатические узлы (nodi bucanatorius);

в) в заушные лимфатические узлы (nodi fymphatici retroauriculares);

г) в подбородочные лимфатические узлы (nodi fymphatici submentales).

64. Чем в основном осуществляется кровоснабжение языка?

а) язычной артерией (a. lingualis);

б) восходящей нёбной артерией (a. patatina ascendens);

в) нисходящей нёбной артерией (a. palatina descendens);

г) восходящей глоточной артерией (a.pharyngea ascendens).

65. Куда оттекает лимфа от языка?

а) в подподбородочные лимфатические узлы (nodi lymphatici submentales);

б) в подчелюстные лимфатические узлы (nodi lymphatici submandibulares);

в) в заглоточные лимфатические узлы (nodi lymphatici retropharyngeales);

г) в сосцевидные лимфатические узлы (nodi lymphatici mastoidei).

66. Назовите двигательный нерв для мышц языка:

а) нижнечелюстной нерв (п. mandibularis);

б) подъязычный нерв (п. hypoglossus);

в) языкоглоточный нерв (п. glossopharyngeum);

г) промежуточный нерв (п. intermedius).

67. Чем осуществляется в основном кровоснабжение щёчной области?

а) лицевой артерией (a. facialis);

б) поперечной артерией лица (a. transversa faciei);

в) подглазничной артерией (a. infraorbitalis);

г) щёчной артерией (a. buccalis).

68. Выберите определение нижней границы шеи:

а) горизонтальная плоскость, проходящая по нижнему краю нижней челюсти и I ребру;

б) фронтальная плоскость, проходящая через поперечные отростки шейных позвонков;

в) яремная вырезка грудины, ключица, линия, проведённая через акромиальный отросток к CVII;

г) горизонтальная плоскость, проведённая через яремную вырезку грудины и I ребро к Th.

69. Какими анатомическими образованиями ограничен лопаточно-ключичный треугольник?

а) верхним брюшком лопаточно-подъязычной мышцы;

б) грудино-ключично-сосцевидной мышцей;

в) ключицей;

г) нижним брюшком лопаточно-подъязычной мышцы.

70. Какие мышцы участвуют в образовании диафрагмы рта?

а) подъязычно-язычная мышца;

б) челюстно-подъязычная мышца;

в) шилоподъязычная мышца;

г) шилоглоточная мышца.

71. Назовите анатомические отделы пищевода:

а) шейный;

б) грудной;

в) диафрагмальный;

г) брюшной.

72. Какова скелетотопия уровней сужений пищевода?

а) на уровне CVI;

б) на уровне бифуркации трахеи;

в) при переходе через диафрагму;

г) на уровне ThXII.

73. Какова синтопия звёздчатого узла?

а) снизу – купол плевры;

б) спереди – позвоночная артерия;

в) спереди – подключичная артерия;

г) снаружи – диафрагмальный нерв.

74. Выберите образования, для которых строит влагалище первая фасция шеи (по Шевкуненко).

а) грудино-ключично-сосцевидная мышца;

б) поднижнечелюстная железа;

в) околоушная железа;

г) подкожная мышца шеи.

75. Выберите образования, для которых строит влагалище вторая фасция шеи (по Шевкуненко):

а) грудино-ключично-сосцевидная мышца;

б) поднижнечелюстная слюнная железа;

в) околоушная слюнная железа;

г) лопаточно-подъязычная мышца.

76. Выберите образования, для которых строит влагалище третья фасция шеи (по Шевкуненко):

а) грудино-ключично-сосцевидная мышца;

б) грудино-подъязычная мышца;

в) грудино-щитовидная мышца;

г) щитоподъязычная мышца.

77. Выберите образования, для которых строит влагалище париетальный листок четвёртой фасции шеи (по Шевкуненко):

а) общая сонная артерия;

б) наружная яремная вена;

в) блуждающий нерв;

г) подключичная артерия.

78. Выберите образования, для которых строит влагалище пятая фасция шеи (по Шевкуненко):

а) подключичная артерия;

б) общая сонная артерия;

в) наружная яремная вена;

г) подключичная вена.

79. Какие возможны осложнения при нарушении целостности венозной стенки на шее?

а) воздушная эмболия;

б) тромбоэмболия;

в) сепсис;

г) флебит.

80. С какими пространствами связано надгрудинное межапоневротическое пространство?

а) пространство между третьей и четвёртой фасциями;

б) пространство между четвёртой и пятой фасциями;

в) пространство, расположенное позади грудино-ключично-сосцевидной мышцы (мешок Грубера);

г) клетчаточное пространство латерального треугольника шеи.

81. Укажите пути распространения гнойных затёков из предвисцерального пространства:

а) в среднее средостение;

б) в переднее средостение;

в) в заднее средостение;

г) в среднее и заднее средостения.

82. Укажите пути распространения гнойных затёков из позадивисцерального пространства:

а) в среднее средостение;

б) в переднее средостение;

в) в заднее средостение;

г) в среднее и заднее средостения.

83. Между какими анатомическими образованиями расположено клетчаточное пространство латерального треугольника шеи?

а) первая фасция шеи;

б) вторая фасция шеи;

в) третья фасция шеи;

г) пятая фасция шеи.

84. С какими анатомическими образованиями сообщается клетчаточное пространство латерального треугольника шеи?

а) с подтрапециевидным пространством;

б) с передним средостением;

в) с надостной ямкой;

г) с ретропекторальным пространством.

85. Чем ограничена надподъязычная область?

а) краем нижней челюсти и верхушкой сосцевидного отростка;

б) телом подъязычной кости;

в) верхним краем щитовидного хряща;

г) задними брюшками двубрюшной мышцы.

86. Назовите треугольники надподъязычной области:

а) подподбородочный;

б) подъязычный;

в) сонный;

г) поднижнечелюстной.

87. Назовите границы подподбородочного треугольника:

а) край нижней челюсти, заднее и переднее брюшки двубрюшной мышцы;

б) передние брюшки двубрюшных мышц и подъязычная кость;

в) оба задних брюшка двубрюшных мышц и подъязычная кость;

г) оба передних брюшка двубрюшных мышц и щитовидный хрящ.

88. Укажите пути распространения воспалительного процесса из ложа поднижнечелюстной железы:

а) в клетчатку дна полости рта;

б) в жировое тело щеки;

в) в клетчатку околоушной железы;

г) в заглоточное пространство.

89. Какие образования проходят в пределах подподьязычной области

между первой и второй фасциями шеи?

а) передние яремные вены;

б) наружные яремные вены;

в) срединная вена шеи;

г) непарная артерия шеи.

90. Какова скелетотопия гортани?

а) от верхнего края C V до нижнего края C VI;

б) от верхнего края C]V до нижнего края C V;

в) от верхнего края C[V до нижнего края C VII;

г) от нижнего края C III, до верхнего края C VI.

91. Выберите источники кровоснабжения гортани:

а) ветви верхней гортанной артерии;

б) ветви нижней гортанной артерии;

в) ветви верхней щитовидной артерии;

г) ветви низшей щитовидной артерии.

92. Выберите источники иннервации гортани:

а) ветви блуждающего нерва;

б) ветви симпатического ствола;

в) ветви диафрагмального нерва;

г) ветви нижнего гортанного нерва.

93. Скелетотопия шейного отдела трахеи:

а) от верхнего края Cv до нижнего края Th2;

б) от уровня яремной вырезки грудины до верхнего края Th3;

в) от верхнего края C[V до верхнего края Th,1;

г) от верхнего края CvII до верхнего края ThIII.

94. Укажите анатомические отделы щитовидной железы:

а) правая доля;

б) передняя доля;

в) перешеек;

г) левая доля.

95. Укажите нервы, участвующие в иннервации щитовидной

железы:

а) симпатический ствол;

б) блуждающий нерв;

в) верхний гортанный нерв;

г) подъязычный нерв.

96. Какова топография паращитовидных желёз?

а) вне собственной капсулы щитовидной железы;

б) между фиброзной капсулой и фасциальным влагалищем щитовидной железы;

в) на передней поверхности щитовидной железы;

г) на задней поверхности боковых долей щитовидных желёз.

97. Укажите анатомические отделы глотки:

а) носовая часть глотки;

б) ротовая часть глотки;

в) зев;

г) гортанная часть глотки.

98. Скелетотопия глотки:

а) от основания черепа до нижнего края CVI;

б) от основания черепа до перехода в пищевод;

в) от основания черепа до верхнего края CVII;

г) от основания черепа до уровня твёрдого нёба.

99. Какие артерии принимают участие в кровоснабжении глотки?

а) восходящая глоточная артерия;

б) восходящая нёбная артерия;

в) добавочная щитовидная артерия;

г) ветви верхней щитовидной артерии.

100. Укажите источники иннервации глотки:

а) блуждающий нерв;

б) языкоглоточный нерв;

в) шейные узлы симпатического ствола;

г) подъязычный нерв.

101. Какова синтопия глотки?

а) спереди — гортань;

б) позади — пятая фасция шеи, покрывающая длинные мышцы шеи;

в) позади — лестничные мышцы шеи во влагалищном футляре пятой фасции шеи;

г) по бокам — доли щитовидной железы.

102. Какова синтопия шейного отдела пищевода?

а) спереди — трахея;

б) сзади — пятая фасция шеи, покрывающая длинные мышцы шеи;

в) справа по задней поверхности трахеи идёт диафрагмальный нерв;

г) в бороздах между трахеей и пищеводом расположены возвратные гор танные нервы.

103. Какие артерии принимают участие в кровоснабжении шейного отдела пищевода?

а) ветви верхней щитовидной артерии;

б) ветви нижней щитовидной артерии;

в) низшая щитовидная артерия;

г) восходящая глоточная артерия.

104. Какие сосудисто-нервные образования расположены под грудино-ключично-сосцевидной мышцей?

а) общая сонная артерия;

б) блуждающий нерв;

в) наружная яремная вена;

г) внутренняя яремная вена.

105. На какой фасции шеи лежит общая сонная артерия в сонном влагалище?

а) на висцеральном листке четвёртой фасции;

б) на пятой фасции;

в) на третьей фасции;

г) на париетальном листке четвёртой фасции.

106. В случае необходимости быстрой остановки кровотечения из

сонной артерии к чему необходимо её прижать?

а) к бугорку поперечного отростка VI шейного позвонка;

б) к бугорку поперечного отростка VII шейного позвонка;

в) на середине переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы;

г) к поперечным отросткам шейных позвонков на уровне перстневидного хряща.

107. Какие образования расположены глубже пятой фасции шеи на уровне общей сонной артерии?

а) блуждающий нерв;

б) симпатический ствол;

в) диафрагмальный нерв;

г) верхняя щитовидная артерия.

108. Какими мышцами образован угол, по биссектрисе которого проходит общая сонная артерия?

а) верхним брюшком лопаточно-подъязычной мышцы;

б) грудино-ключично-сосцевидной мышцей;

в) передним брюшком двубрюшной мышцы;

г) задним брюшком двубрюшной мышцы.

109. Укажите первую ветвь наружной сонной артерии на шее:

а) лицевая артерия;

б) верхняя щитовидная артерия;

в) язычная артерия;

г) верхнечелюстная артерия.

110. Какие нервы пересекают наружную и внутреннюю сонные артерии в косопоперечном направлении?

а) возвратный нерв;

б) нижний гортанный нерв;

в) верхний гортанный нерв;

г) блуждающий нерв.

111. Укажите топографию сосудисто-нервного пучка в пределах сонного треугольника справа налево:

а) общая сонная артерия, внутренняя яремная вена, блуждающий нерв;

б) блуждающий нерв, внутренняя яремная вена, общая сонная артерия;

в) внутренняя яремная вена, блуждающий нерв, общая сонная артерия;

г) наружная яремная вена, блуждающий нерв, общая сонная артерия.

112. Укажите узлы только шейной части симпатического ствола:

а) верхний;

б) средний;

в) нижний;

г) звёздчатый.

113. Где расположены шейные узлы симпатического нервного ствола?

а) на лестничных мышцах шеи;

б) на длинных мышцах головы и шеи;

в) впереди пятой фасции шеи;

г) позади или в толще пятой фасции шеи.

114. Какие анатомические образования впадают в яремный венозный угол?

а) наружная яремная вена;

б) внутренняя яремная вена;

в) грудной лимфатический проток;

г) правый лимфатический проток.

115. Какие нервы участвуют в построении диафрагмального нерва?

а) четвёртый шейный нерв;

б) третий шейный нерв;

в) пятый шейный нерв;

г) шестой шейный нерв.

116. Как расположен диафрагмальный нерв?

а) вдоль наружного края передней лестничной мышцы;

б) по задней поверхности передней лестничной мышцы;

в) по передней поверхности передней лестничной мышцы;

г) по наружной поверхности средней лестничной мышцы.

117. Какая мышца участвует в формировании латеральной стенки лестнично-позвоночного треугольника?

а) грудино-подъязычная мышца;

б) задняя лестничная мышца;

в) грудино-щитовидная мышца;

г) передняя лестничная мышца.

118. Какая мышца участвует в формировании медиальной стенки лестнично-позвоночного треугольника?

а) грудино-подъязычная мышца;

б) задняя лестничная мышца;

в) грудино-шитовидная мышца;

г) длинная мышца шеи.

119. Какое анатомическое образование служит основанием лестнично-позвоночного треугольника?

а) подлопаточная мышца;

б) купол плевры;

в) ключица;

г) подключичная артерия.

120. Какая фасция покрывает анатомические образования, расположенные в лестнично-позвоночном треугольнике?

а) первая фасция шеи;

б) вторая фасция шеи;

в) третья фасция шеи;

г) пятая фасция шеи.

121.Что расположено в пределах лестннчно-позвоночного треугольника впереди правой подключичной артерии?

а) яремный венозный угол;

б) передняя яремная вена;

в) внутренняя яремная вена;

г) наружная яремная вена.

122. Какие образования проходят в правом лестнично-позвоночном

треугольнике позади подключичной артерии?

а) блуждающий нерв;

б) возвратный гортанный нерв;

в) диафрагмальный нерв;

г) надлопаточная артерия.

123. Какие образования лежат впереди подключичной артерии в левом лестнично-позвоночном треугольнике?

а) общая сонная артерия;

б) блуждающий нерв;

в) диафрагмальный нерв;

г) внутренняя яремная вена.

124. Какие образования проходят в лестнично-позвоночном треугольнике медиальнее левой подключичной артерии?

а) блуждающий нерв;

б) возвратный гортанный нерв;

в) диафрагмальный нерв;

г) надлопаточная артерия.

125. Выберите мышцы, между которыми расположена позвоночная артерия после отхождення подключичной артерии:

а) передняя лестничная мышца;

б) средняя лестничная мышца;

в) длинная мышца шеи;

г) задняя лестничная мышца.

126. Какие образования расположены кпереди от грудного лимфатического протока в пределах лестнично-позвоночного треугольника?

а) общая сонная артерия;

б) внутренняя яремная вена;

в) иафрагмальный нерв;

г) блуждающий нерв.

127. Назовите ветви щитошейного ствола:

а) ижняя щитовидная артерия;

б) восходящая шейная артерия;

в) адлопаточная артерия;

г) поперечная артерия шеи.

128. Какие образования расположены позади от грудного лимфатического протока?

а) общая сонная артерия;

б) внутренняя яремная вена;

в) диафрагмальный нерв;

г) блуждающий нерв.

129. Где в ране следует искать наружную сонную артерию?

а) ежду лицевой веной и подъязычным нервом;

б) между лицевой артерией и подъязычным нервом;

в) ежду лицевой и щитовидной артериями;

г) между щитовидной артерией и лицевой веной.

130. Какие нервы могут быть вовлечены в инфильтрат при вагосимпатической блокаде по Вишневскому?

а) блуждающий;

б) симпатический ствол;

в) диафрагмальный;

г) подъязычный.

131. Выберите осложнения трахеостомии при разрезе не по срединной линии шеи:

а) повреждение поверхностных вен шеи;

б) воздушная эмболия;

в) повреждение сонной артерии;

г) вскрытие трахеи.

132. Выберете осложнения при недостаточном гемостазе при проведении трахеостомии:

а) снижение концентрации гемоглобина;

б) уменьшение количества эритроцитов;

в) аспирационная пневмония;

г) асфиксия.

133. В чём необходимо убедиться перед введением

трахеостомической канюли в просвет трахеи?

а) произведён тщательный гемостаз;

б) вскрыт просвет трахеи;

в) рассечена слизистая оболочка трахеи;

г) рассечена подслизистая оболочка трахеи.

134. По каким признакам определяют пищевод во время операции?

а) по продольно идущим мышечным волокнам;

б) по буровато-красному цвету;

в) по пульсирующей стенке;

г) по циркулярным мышечным волокнам.

135. Перечислите основные приёмы профилактики рецидива

токсического зоба при операции, предложенной О. В. Николаевым:

а) минимальная травматизация тканей щитовидной железы;

б) тщательный гемостаз;

в) промывание раны раствором новокаина для удаления токсичных

продуктов;

г) оптимальная анестезия операционной области.

136. Какие виды трахеотомии различают по отношению к

перешейку щитовидной железы?

а) верхнюю трахеотомию;

б) нижнюю трахеотомию;

в) парамедиальную трахеотомию;

г) боковую трахеотомию.

DOGANLAR OKAMALIDA NIMSHETTILARIN ☺

Тема № 2

Топография грудной клетки и органов грудной полости. Операции

на грудной клетке и органах грудной полости

1. Какой фасцией грудной стенки образована капсула молочной

железы?

а) собственной фасцией груди;

б) поверхностной;

в) ключично-грудной;

г) внутригрудной.

2. Где находится лимфатический узел Зоргиуса?

а) под ключицей позади грудино-ключично-сосцевидной мышцы;

б) по ходу внутренней грудной артерии;

в) в центре подмышечной впадины;

г) под наружным краем большой грудной мышцы на уровне III ребра.

3. Какие разрезы используются для вскрытия гнойных маститов?

а) радиальные по отношению к соску;

б) дугообразный по ходу переходной складки молочной железы;

в) крестообразный;

г) продольный (вертикальный).

4. При радикальной мастэктомии удаляется:

а) молочная железа + подмышечные узлы;

б) молочная железа + грудные мышцы + региональные лимфатические

узлы;

в) молочная железа;

г) молочная железа + малая грудная мышца.

5. В каком слое грудной стенки расположен межреберный

сосудисто-нервный пучок?

а) под грудной фасцией;

б) между межреберными мышцами;

в) в параплевральной клетчатке;

г) под поверхностной фасцией.

6. Какое _____мнемоническое правило применяется для запоминания

расположения элементов межреберного сосудисто-нервного пучка?

а) НеВА;

б) ВАНя;

в) ВеНА;

г) НАВ.

7. В каком слое грудной стенки располагается внутренняя грудная артерия?

а) в субпекторальной клетчатке;

б) между межреберными мышцами;

в) между внутренними межреберными мышцами и поперечной мышцей груди;

г) между fascia endothoracica и париетальной плеврой.

8. По какому краю ребра производится вкол иглы при пункции плевральной полости?

а) вблизи верхнего края ребра;

б) по нижнему краю ребра;

в) по середине межреберья;

г) в любой из вышеперечисленных точек.

9. Как рассекается надкостница при поднадкостничной резекции ребра?

а) П-образно;

б) дугообразно;

в) линейным разрезом;

г) Н-образно.

10. Какой анатомический слой грудной стенки должен быть поврежден, чтобы ранение называлось проникающим?

а) кожа;

б) кожа и подкожная жировая клетчатка;

в) кожа, подкожная жировая клетчатка и мышцы;

г) все вышеперечисленные слои и внутригрудная фасция.

11. Сколько серозных полостей в грудной полости?

а) одна;

б) две;

в) три;

г) четыре.

12. Какой из синусов плевры наиболее крупный и глубокий?

а) диафрагмо-медиастинальный правый;

б) реберно-медиастинальный передний;

в) реберно-диафрагмальный;

г) реберно-медиастинальный задний.

13. Какие виды раневого пневмоторакса Вы знаете?

а) открытый;

б) закрытый;

в) комбинированный;

г) клапанный.

14. С какой целью производится вагосимпатическая блокада при ранениях груди?

а) для обезболивания;

б) для уменьшения явлений гипоксии;

в) как способ борьбы с плевро-пульмональным шоком;

г) для профилактики пневмонии.

15. Какие слои нужно захватить в первый ряд швов при простом ушивании открытого пневмоторакса?

а) париетальную плевру и внутригрудную фасцию;

б) париетальную плевру;

в) все слои грудной стенки;

г) париетальную плевру, внутригрудную фасцию, межреберные мышцы.

16. В каких случаях при первичной хирургической обработке проникающих ранений груди производится ревизия грудной полости?

а) во всех случаях;

б) при прогрессирующем ухудшении состояния раненого;

в) при симптомах массивного непрекращающегося внутреннего кровоте чения;

г) при повреждениях ткани легкого.

17. Какой элемент является основным при оказании первой

врачебной помощи при клапанном пневмотораксе?

а) вагосимпатическая блокада;

б) наложение асептической окклюзионной повязки;

в) перевод пострадавшего в полусидячее положение;

г) пункция плевральной полости.

18. Какой элемент занимает самое верхнее положение в корне правого легкого?

а) легочная вена;

б) легочная артерия;

в) главный бронх;

г) ветви диафрагмального нерва.

19. Какой элемент занимает самое верхнее положение в корне левого легкого?

а) легочная вена;

б) главный бронх;

в) легочная артерия;

г) диафрагмальный нерв.

20. Сколько бронхолегочных сегментов выделяют в правом легком?

а) пять;

б) шесть;

в) десять;

г) одиннадцать.

21. Сколько бронхолегочных сегментов выделяют в левом легком?

а) одиннадцать;

б) семь;

в) восемь;

г) десять.

22. Где проходит граница между передним и задним средостением?

а) по аорте;

б) по пищеводу;

в) по задней поверхности трахеи и главных бронхов;

г) за вилочковой железой.

23. Сколько ветвей обычно отходят от выпуклой части дуги аорты?

а) пять;

б) две;

в) шесть;

г) три.

24. Какое анатомическое образование располагается вдоль правой стенки верхней полой вены?

а) корень правого легкого;

б) правый блуждающий нерв;

в) правый диафрагмальный нерв;

г) грудная часть грудного протока.

25. В какую стенку верхней полой вены чаще впадает непарная вена?

а) в заднюю;

б) в переднюю;

в) в правую;

г) в левую.

26. Какие нервы находятся на передней поверхности дуги аорты?

а) правый блуждающий нерв;

б) левый блуждающий нерв;

в) левый диафрагмальный нерв;

г) правый диафрагмальный нерв.

27. Какую поверхность корней легких пересекают диафрагмальные нервы?

а) переднюю;

б) заднюю;

в) верхнюю;

г) нижнюю.

28. Является ли осмотр задней стенки сердца при его ранении обязательным элементом операции?

а) да, является обязательным элементом операции во избежание грубой

ошибки;

б) осмотр задней стенки сердца обычно не производится из-за дефицита времени;

в) осмотр задней стенки сердца выполняется только при признаках ее повреждения;

г) производится только при широком доступе.

29. Уровню каких позвонков соответствует бифуркация трахеи?

а) TIII;

б) TIV-TV;

в) TI-TII;

г) TVI-TVII.

30. В каком порядке сверху вниз располагаются элементы корня левого легкого?

а) главный бронх, легочная артерия, легочные вены;

б) легочная артерия, главный бронх, легочные вены;

в) легочные вены, главный бронх, легочная артерия;

г) легочные вены, легочная артерия, главный бронх.

31. В каком порядке сверху вниз располагаются элементы корня правого легкого?

а) главный бронх, легочная артерия, легочные вены;

б) легочная артерия, главный бронх, легочные вены;

в) легочная артерия, легочные вены, главный бронх;

г) легочные вены, главный бронх, легочная артерия.

32. К какому анатомическому образованию, кроме позвоночника, прилежит на всем протяжении в заднем средостении пищевод?

а) к полунепарной вене;

б) к левому симпатическому стволу;

в) к грудному протоку;

г) к грудной части нисходящей аорты.

33. На какой поверхности пищевода располагаются ветви левого блуждающего нерва в грудной полости?

а) на передней поверхности;

б) на задней поверхности;

в) на левой поверхности;

г) на правой поверхности.

34. Какой фактор является ведущим в развитии заднего

медиастинита?

а) огнестрельные ранения;

б) прободение пищевода инородными телами;

в) распространение метастатическим путем;

г) переход гнойного процесса в заднее средостение при флегмонах шеи.

35. Из каких структур состоит грудная клетка?

а) из рёбер и грудины;

б) из рёбер, грудины и диафрагмы;

в) из истинных рёбер и грудины;

г) из рёбер, грудины и позвоночника.

36. Что такое плевральный синус?

а) полость в средостении;

б) полость в лёгком;

в) полость, куда заходит лёгкое;

г) часть плевральной полости, ограниченная двумя отделами

пристеночной плевры.

37. Что такое ворота лёгкого?

а) бронх, лёгочная артерия и вена;

б) сосуды лёгкого, покрытые плеврой;

в) место в лёгком, куда входят и откуда выходят сосуды и бронх;

г) вдавление на медиальной поверхности плевры.

38. Что такое корень лёгкого?

а) место выхода крупных сосудов;

б) бронх, артерия, вены, покрытые висцеральной плеврой;

в) место перехода пристеночной плевры в висцеральную;

г) цепь лимфатических сосудов в области ворот лёгкого.

39. Куда происходит внутрикожный поверхностный лимфоотток

от молочной железы?

а) на противоположную сторону;

б) в лимфатические узлы средостения;

в) в надключичные и подключичные лимфатические узлы;

г) в лимфатические узлы переднего средостения.

40. Какие части различают в диафрагме?

а) переднюю, заднюю и латеральную части;

б) сухожильный центр, заднюю и верхнюю части;

в) грудинную, рёберную и поясничную части, сухожильный центр;

г) переднюю и заднюю части.

41. Где проходит нижняя полая вена через диафрагму?

а) между ножками диафрагмы через отверстие нижней полой вены;

б) через пояснично-рёберный треугольник;

в) в сухожильном центре через отверстие нижней полой вены;

г) через грудино-рёберный треугольник.

42. На чём основано долевое деление лёгких?

а) на делении лёгочных артерий;

б) на делении лёгочных вен;

в) на делении бронхов;

г) на распределении регионарных лимфатических узлов.

43. Что переходит через правый бронх, идя сзади наперёд?

а) блуждающий нерв;

б) диафрагмальный нерв;

в) непарная вена;

г) правый возвратный гортанный нерв.

44. Откуда берёт начало лёгочный ствол?

а) от правого желудочка;

б) от левого предсердия;

в) от левого желудочка;

г) от правого предсердия.

45. Куда впадает верхняя полая вена?

а) в левое предсердие;

б) в левый желудочек;

в) в правое предсердие;

г) в правый желудочек.

46. Чем ограничена косая пазуха перикарда?

а) спереди — левым желудочком;

б) спереди — задней поверхностью левого предсердия;

в) сверху — основанием левой нижней лёгочной вены;

г) слева — аортой.

47. Что ложится на переднюю поверхность дуги аорты?

а) лёгочный ствол;

б) верхняя полая вена;

в) блуждающий и диафрагмальный нервы;

г) нижняя полая вена.

48. Куда впадают лёгочные вены?

а) в правый желудочек;

б) в левый желудочек;

в) в правое предсердие;

г) в левое предсердие.

49. От каких нервов отходят возвратные гортанные нервы?

а) от блуждающих;

б) от диафрагмальных;

в) от симпатического ствола;

г) от чревных нервов.

50. Почему опасно повреждение возвратных гортанных нервов?

а) появляется дисфагия;

б) возникает дрожание голоса;

в) наступает асфиксия;

г) возникает афония.

51. Где проходит правый диафрагмальный нерв ниже корня правого

лёгкого?

а) между висцеральной и пристеночной плеврой;

б) между висцеральной плеврой и перикардом;

в) между медиастинальной плеврой и перикардом;

г) между двумя листками висцеральной плевры.

52. Где проходит левый днафрагмальный нерв ниже корня левого лёгкого?

а) между пристеночной и висцеральной плеврой;

б) между двумя листками висцеральной плевры;

в) между медиастинальной плеврой и перикардом;

г) между двумя листками пристеночной плевры.

53. Что лежит справа от трахеи в средостении?

а) плечеголовной ствол и пищевод;

б) верхняя полая вена и симпатический ствол;

в) правый блуждающий нерв;

г) вилочковая железа и лимфатические узлы.

54. Что проходит позади левого бронха?

а) грудной лимфатический проток;

б) левый плечеголовной ствол;

в) правый плечеголовной ствол;

г) пищевод, дуга аорты, левый нерв.

55. Какой нерв сопровождает пищевод в заднем средостении?

а)диафрагмальный;

б) большой чревный;

в) малый чревный;

г) блуждающие нервы.

56. На уровне какого позвонка пищевод проходит через диафрагму?

а) Th X;

б) Th IX;

в) Th VIII;

г) Th VII.

57. Какой синус плевральной полости пунктируют при гнойном плеврите?

а) диафрагмально-медиастинальный;

б) рёберно-диафрагмальный;

в) рёберно-медиастинальный;

г) правый брыжеечный.

58. В каком межреберье делают плевральную пункцию?

а) в третьем;

б) в четвёртом;

в) в пятом;

г) в восьмом.

59. Через что подходят к предсердно-желудочковому отверстию при митральной комиссуротомии?

а) через правый желудочек;

б) через левый желудочек;

в) через левое ушко;

г) через правое ушко.

60. Как поступают с перикардом после ушивания раны сердца?

а) ушивают наглухо;

б) не ушивают;

в) ушивают частыми узловыми швами;

г) ушивают редкими узловыми швами.

61. Какими швами ушивают раны сердца?

а) по Альберту;

б) по Шмидену;

в) отдельными узловыми швами;

г) швы проходят через эпикард.

62. Указывает ли появление слоновости верхней конечности на хирургическую ошибку при мастэктомии?

а) да, поскольку было убрано большое количество клетчатки;

б) нет, так как это указывает на радикальность операции;

в) хирургом повреждены вены подкрыльцовой ямки;

г) хирург пересёк нервы в подмышечной впадине.

63. Какие мышцы должны быть убраны при мастэктомии?

а) широчайшая мышца спины и подключичная мышца;

б) большая и малая грудные мышцы;

в) передняя зубчатая и трапециевидная мышцы;

г) подлопаточная и малая круглая мышцы.

Тема № 3

Топография передней брюшной стенки. Хирургическая анатомия

грыж. Топография органов брюшной полости

1. Чем иннервируются мышцы переднебоковой брюшной стенки?

а) боковыми и передними ветвями межреберных нервов от 4 до 10;

б) боковыми и передними ветвями межреберных нервов от 7 до 12;

в) ветвями поясничного сплетения;

г) ветвями крестцового сплетения.

2. Какой слой находится позади поперечной мышцы живота?

а) брюшина;

б) предбрюшинная клетчатка;

в) внутрибрюшная фасция;

г) сухожильное растяжение.

3. За счет каких элементов образуется белая линия живота?

а) апоневроза наружной косой мышцы живота;

б) апоневроза внутренней косой мышцы живота;

в) апоневроза поперечной мышцы живота;

г) сухожильных пучков шести широких мышц живота.

4. Какие слои имеет брюшная стенка в пределах пупочного кольца?

а) кожа;

б) подкожная жировая клетчатка;

в) поверхностная фасция;

г) пупочная фасция.

5. Что является границами пахового треугольника?

а) горизонтальная линия, проведенная от верхней передней подвздошной ости до пупка;

б) паховая связка;

в) горизонтальная линия, проведенная от границы между наружной и средней третями длины паховой связки;

г) наружный край прямой мышцы живота.

6. Сколько элементов можно выделить в паховом канале?

а) 3 стенки и 3 отверстия;

б) 4 стенки и 4 отверстия;

в) 4 стенки и 2 отверстия;

г) 2 стенки и 4 отверстия.

7. Чем образована верхняя стенка пахового канала?

а) наружной косой мышцей живота;

б) внутренней косой мышцей живота;

в) поперечной мышцей живота;

г) паховой связкой.

8. Что такое «паховый промежуток»?

а) расстояние между наружным и внутренним кольцами пахового канала;

б) расстояние между паховой связкой и нижним краем внутренней косой и поперечной мышц живота;

в) расстояние между паховой связкой и поперечной мышцей;

г) расстояние между передней и задней стенками пахового канала.

9. Чем образовано поверхностное паховое кольцо?

а) внутрибрюшной фасцией;

б) расщеплением паховой связки;

в) расщеплением апоневроза наружной косой мышцы живота;

г) внутренней косой и поперечной мышцами живота.

10. Какой ямке соответствует внутреннее отверстие пахового канала?

а) латеральной;

б) медиальной;

в) надпузырной;

г) нижней.

11. Что является анатомической предпосылкой образования

паховых грыж?

а) наличие пахового промежутка;

б) наличие широкого пахового промежутка;

в) наличие узкого пахового промежутка;

г) отсутствие пахового промежутка.

12. Как можно подразделить способы укрепления грыжевых ворот

при грыжах переднебоковой брюшной стенки?

а) простые;

б) сложные;

в) комбинированные;

г) реконструктивные.

13. При каких видах грыж обязательно укрепляют заднюю стенку

пахового канала?

а) при косой паховой грыже;

б) при прямой паховой грыже;

в) при врожденной паховой грыже;

г) при ущемленной грыже.

14. Где располагается разрез при операции по поводу паховой грыжи?

а) параллельно паховой связке на 2 см ниже нее;

б) параллельно паховой связке на 2 см выше нее;

в) по проекции паховой связки;

г) над грыжевым мешком.

15. Какие слои подшиваются к паховой связке при пластике

грыжевых ворот по способу Жирара — Спасокукоцкого?

а) апоневроз наружной косой мышцы живота;

б) внутренняя косая и поперечная мышцы живота;

в) апоневроз наружной косой мышцы живота вместе с внутренней косой

и поперечной мышцами живота;

г) поперечная фасция.

16. Какие слои подшиваются к паховой связке при пластике

грыжевых ворот по способу Бассини?

а) апоневроз наружной косой мышцы живота;

б) внутренняя косая и поперечная мышцы живота вмесге с поперечной

фасцией;

в) апоневроз наружной косой мышцы живота вместе с внутренней косой

и поперечной мышцами;

г) поперечная фасция.

17. Сколько элементов имеет бедренный канал?

а) 2 отверстия и 2 стенки;

б) 2 отверстия и 3 стенки;

в) 2 отверстия и 4 стенки;

г) 3 отверстия и 2 стенки.

18. Где находится наружное отверстие бедренного канала?

а) в поверхностной фасции;

б) в апоневрозе наружной косой мышцы живота;

в) в широкой фасции бедра;

г) в передней стенке футляра прямой мышцы живота.

19. Какие ткани сшиваются при операции бедренной грыжи

бедренным способом по Бассини?

а) паховая связка с лакунарной;

б) паховая связка с гребешковой;

в) внутренняя косая и поперечная мышцы с паховой и гребенчатой

связками;

г) апоневроз наружной косой мышцы живота с гребенчатой связкой.

20. В чем заключается недостаток способа пластики грыжевых

ворот по Бассини при бедренной грыже?

а) в возможности сдавления большой подкожной вены;

б) в возможности увеличения пахового промежутка при смещении вниз

паховой связки;

в) в возможности сдавления сосудисто-нервного пучка бедра;

г) в возможности формирования грубого послеоперационного рубца.

21. В чем заключается преимущество пластики грыжевых ворот по способу Парлавеччио?

а) менее травматичен;

б) прост в выполнении;

в) укрепление бедренного кольца и пахового промежутка;

г) уменьшение вероятности повреждения бедренных сосудов.

22. Соединяется ли непосредственно правая печеночная сумка с правым боковым каналом?

а) да, соединяется непосредственно;

б) нет, не соединяется;

в) обычно правая печеночная пазуха перекрыта правой ободочно-диафрагмальной связкой;

г) степень соединения зависит от величины преджелудочного пространства.

23. Что является границей между верхним и нижним этажами брюшной полости?

а) горизонтальная плоскость, проведенная через нижние края реберных дуг;

б) горизонтальная плоскость, проведенная через пупок;

в) малый сальник;

г) поперечная ободочная кишка и ее брыжейка.

24. Чем ограничена правая печеночная сумка?

а) диафрагмой;

б) поверхностью правой доли печени;

в) венечной связкой печени;

г) серповидной связкой печени.

25. Какие элементы входят в состав печеночно-двенадцатиперстной связки?

а) воротная вена;

б) нижняя полая вена;

в) собственная печеночная артерия;

г) общий печеночный проток.

26. Как покрыта слепая кишка брюшиной в большинстве случаев?

а) брюшиной слепая кишка не покрыта;

б) покрыта брюшиной с одной стороны;

в) покрыта брюшиной с трех сторон;

г) покрыта брюшиной со всех сторон.

27. Как покрыта поперечная ободочная кишка брюшиной?

а) покрыта со всех сторон;

б) покрыта с одной стороны;

в) покрыта с двух сторон;

г) покрыта с трех сторон.

28. Как покрыта брюшиной восходящая ободочная кишка?

а) брюшиной не покрыта;

б) покрыта с одной стороны;

в) покрыта с двух сторон;

г) покрыта с трех сторон.

29. Какие элементы образуют сальниковое отверстие?

а) дно желчного пузыря;

б) печеночно-почечная связка;

в) верхний конец правой почки;

г) печеночно-двенадцатиперстная связка.

30. Какой признак позволяет отличить поперечную ободочную

кишку от остальных отделов ободочной кишки?

а) большое количество жировых подвесок;

б) наличие большого сальника;

в) ориентация в поперечном направлении;

г) наличие мышечных лент.

31. По каким абсолютным признакам можно отличить тонкую

кишку от толстой?

а) по отсутствию сальниковых отростков;

б) по отношению к брюшине;

в) по отсутствию вздутий на протяжении кишки;

г) по цвету.

32. Какие связки образуют малый сальник?

а) желудочно-селезеночная;

б) печеночно-желудочная;

в) печеночно-двенадцатиперстная;

г) диафрагмально-желудочная.

33. В чем заключается наибольшая трудность в наложении узловых швов на рану печени и селезенки?

а) в возможности прорезывания швов;

б) в трудности завязывания узлов;

в) в возможности повреждения крупных внутриорганных сосудов;

г) наложение швов не представляет технических трудностей.

34. С какой стороны рекомендуется обходить пупок при выполнении срединной лапаротомш?

а) с правой стороны;

б) с левой стороны;

в) выбор стороны не имеет значения.

35. В какую часть двенадцатиперстной кишки обычно открываются общий желчный и панкреатический протоки?

а) в восходящую часть;

б) в нисходящую часть;

в) в горизонтальную часть;

г) в верхнюю часть.

36. Какие части различают на протяжении двенадцатиперстной кишки?

а) верхнюю;

б) заднюю;

в) нижнюю;

г) нисходящую.

37. Из каких источников обычно кровоснабжается

двенадцатиперстная кишка?

а) из левой почечной артерии;

б) из нижней брыжеечной артерии;

в) из чревного ствола;

г) из верхней брыжеечной артерии.

38. В какую вену оттекает кровь от двенадцатиперстной кишки?

а) в воротную вену;

б) в нижнюю полую вену;

в) в воротную и нижнюю полую вены;

г) в нижнюю и верхнюю полые вены.

39. В каком направлении ориентирован корень брыжейки тонкой

кишки?

а) поперечно слева направо;

б) косо сверху вниз и слева направо;

в) продольно;

г) косо сверху вниз и справа налево.

40. Как относится тощая и подвздошная кишка к брюшине?

а) обе экстраперитонеально;

б) обе мезоперитонеально;

в) обе интраперитонеально;

г) тощая кишка интраперитонеально, подвздошная —

мезоперитонеально.

41. Какие отделы входят в состав ободочной кишки?

а) восходящая;

б) поперечная;

в) нисходящая;

г) сигмовидная.

42. Какие ветви начинаются от нижней брыжеечной артерии?

а) правая ободочная артерия;

б) левая ободочная артерия;

в) сигмовидная артерия;

г) верхняя прямокишечная артерия.

43. Какие ветви начинаются от верхней брыжеечной артерии?

а) подвздошно-ободочная артерия;

б) правая ободочная артерия;

в) левая ободочная артерия;

г) средняя ободочная артерия.

44. Какие артерии кровоснабжают тощую кишку и подвздошную кишку?

а) ветви чревного ствола;

б) ветви верхней брыжеечной артерии;

в) ветви нижней брыжеечной артерии;

г) ветви верхней и нижней брыжеечных артерий.

45. Какие артерии принимают участие в кровоснабжении ободочной кишки?

а) ветви нижней брыжеечной артерии;

б) ветви верхней брыжеечной артерии;

в) ветви чревного ствола (селезеночная артерия);

г) ветви верхней и нижней брыжеечных артерий.

46. С какой стороны следует производить подход к задней поверхности нисходящей или восходящей ободочной кишки?

а) со стороны бокового канала;

б) со стороны брыжеечной пазухи (синуса);

в) в направлении сверху вниз;

г) в направлении снизу вверх.

47. К какому элементу кишки относится каламбур «толстая кишка тонкая, а тонкая кишка толстая»?

а) к толщине стенки;

б) к наружному диаметру;

в) к внутреннему диаметру;

г) это бессодержательная игра слов.

48. Какой принцип положен в основу подразделения печени на сегменты по Куино?

а) ≪кавальный принцип≫, то есть разделение на сегменты в соответствии с ходом притоков печеночных вен;

б) ≪воротный принцип≫, то есть по ветвям воротной вены;

в) в соответствии с топографией желчных путей;

г) принцип выделения 8 сегментов равного объема.

49. С какой целью применяется тампонада ран паренхиматозных органов свободными сальниковыми фрагментами или сальниковыми лоскутами на ножке?

а) для предупреждения инфицирования полости брюшины;

б) для предупреждения развития в последующем спаечной болезни;

в) для более эффективной остановки кровотечения;

г) для лучшего всасывания раневого отделяемого.

50. По каким признакам можно распознать повреждение двенадцатиперстной кишки?

а) по появлению забрюшинной гематомы;

б) по желчному прокрашиванию забрюшинного пространства;

в) по наличию пузырьков воздуха в забрюшинном пространстве;

г) по газовому пузырю в поддиафрагмальном пространстве.

51. С помощью каких доступов можно подойти к задней стенке желудка?

а) через бессосудистую зону брыжейки поперечной ободочной кишки;

6) после рассечения желудочно-селезеночной связки;

в) после рассечения в бессосудистой зоне малого сальника;

г) после рассечения в бессосудистой зоне желудочно-ободочной связки.

52. Из каких сосудов обычно отходят артерии к желудку?

а) из селезеночной артерии;

б) из общей печеночной артерии;

в) из нижней брыжеечной артерии;

г) из верхней брыжеечной артерии.

53. Как спускается пищевод в брюшную полость?

а) между латеральной и медиальной ножками диафрагмы; через медиаль

ную щель левой ножки;

б) между внутренней и медиальной ножками диафрагмы; через латераль

ную щель левой ножки;

в) между правой и левой ножками;

г) через отверстие нижней полой вены (foramen и cava inferior).

54. Какие отделы толстой кишки расположены

мезоперитонеально?

а) слепая и восходящая ободочная кишки;

б) восходящая ободочная, нисходящая ободочная кишки и ампула

прямой кишки;

в) поперечная ободочная и нисходящая ободочная кишки;

г) сигмовидная, ободочная и прямая кишки.

55. Куда идёт отток венозной крови от прямой кишки?

а) в селезёночную вену;

б) в верхнюю брыжеечную вену;

в) в нижнюю брыжеечную вену;

г) во внутреннюю подвздошную вену.

56. Как распространяется гной при перфоративном аппендиците?

а) по правому продольному каналу;

б) по левому продольному каналу.

в) по ходу тонкой кишки;

г) по забрюшинному пространству.

57. Как воспалительный процесс может перейти из забрюшинной

клетчатки на подсерозную основу пристеночной плевры?

а) сформировав кишечный свищ;

б) через пояснично-грудной треугольник (Богдалека);

в) между ножками диафрагмы;

г) через печёночную сумку.

58. Как проходит поверхностная надчревная артерия (a. epigastrica superficialis)?

а) между наружной и внутренней косой мышцами живота;

б) между апоневрозами мышц передней брюшной стенки;

в) в подкожной жировой клетчатке между листками поверхностной фас ции;

г) между поверхностным и глубоким листками поверхностной фасции.

59. Где проходят основные стволы межрёберных артерий на брюшной стенке?

а) между внутренней косой и поперечной мышцами живота;

б) между наружной и внутренней косой мышцами живота;

в) между листками апоневроза внутренней и наружной косой мышц живота;

г) между париетальной брюшиной и поперечной фасцией.

60. Чем осуществляется иннервация области пахового канала?

а) подвздошно-подчревным нервом (n. iliohipogastricus);

б) подвздошно-паховым нервом (п.ilioingunalis);

в) бедренно-половым нервом (п. genitofemoralis);

г) всеми перечисленными нервами.

61. Где расположена нижняя надчревная артерия (a. epigastrica inferior)?

а) между внутренней косой и поперечной мышцами живота;

б) между поперечной мышцей живота и брюшиной;

в) между поперечной фасцией и брюшиной;

г) между апоневрозами наружной косой и внутренней косой мышц живота.

62. При оперативном лечении какой грыжи хирург может столкнуться с «венцом смерти» (corona mortis)?

а) косой паховой грыжи;

б) ущемлённой прямой паховой грыжи;

в) ущемлённой бедренной грыжи;

г) грыжи запирательного отверстия.

63. Чем построена передняя стенка пахового канала?

а) поверхностной фасцией;

б) наружной косой мышцей живота;

в) поперечной мышцей живота;

г) апоневрозом наружной косой мышцы живота.

64. Что служит нижней стенкой пахового канала?

а) поперечная фасция;

б) нижний край наружной косой мышцы живота;

в) лакунарная связка;

г) паховая связка.

65. Чем отделена латеральная ямка от медиальной на задней поверхности брюшной стенки?

а) срединной пупочной складкой (plica umbilicalis mediana);

б) медиальной пупочной складкой (plica umbilicalis medialis);

в) латеральной пупочной складкой (plica umbilicalis lateralis);

г) пупочной артерией (a. umbilicalis).

66. Какие вены связывают вены брюшной стенки с воротной веной (v. portae)?

а) околопупочные вены (vv. Paraumbilicales;

б) яичковая вена (v. testicularis);

в) нижняя надчревная вена (v. epigastrica inferior);

г) верхняя надчревная вена (v. epigastrica superior).

67. Где формируется воротная вена?

а) в брюшной полости;

б) в забрюшинном пространстве;

в) впереди головки поджелудочной железы;

г) позади головки поджелудочной железы.

68. Позади какой части двенадцатиперстной кишки проходит воротная вена?

а) позади верхней части;

б) позади нисходящей части;

в) позади нижней горизонтальной части;

г) позади восходящей части.

69. Где лежит общий жёлчный проток (ductus choledochus) по отношению к воротной вене (v. portae)?

а) спереди;

б) сзади;

в) справа;

г) слева.

70. Куда течет кровь по воротной вене?

а) в нижнюю полую вену;

б) в верхнюю полую вену;

в) в печень;

г) из печени.

71. Чем образуется печёночно-дуоденальная связка (lig. hepatoduodenale)?

а) брюшиной и поперечной фасцией;

б) париетальной брюшиной;

в) двумя листками висцеральной брюшины;

г) поперечной фасцией и апоневрозом поперечной мышцы.

72. Какой стенкой сальникового отверстия является печёночно-дуоденальная связка (lig. hepatoduodenale)?

а) передней;

б) задней;

в) верхней;

г) нижней.

73. Откуда начинается левая желудочная артерия (a. gastrica sinistra)?

а) от верхней брыжеечной артерии;

б) от нижней брыжеечной артерии;

в) от чревного ствола;

г) от селезёночной артерии.

74. Откуда начинается правая желудочная артерия (a. gastrica dextra)?

а) от чревного ствола;

б) от общей печёночной артерии;

в) от собственной печёночной артерии;

г) от селезёночной артерии.

75. Где расположен основной ствол левой желудочной артерии (a. gastrica sinistra)?

а) в печёночно-желудочной связке;

б) в диафрагмально-жедудочной связке;

в) в желудочно-поджелудочной связке;

г) в желудочно-сальниковой связке.

76. Что образует переднюю стенку сальниковой сумки?

а.) малый сальник и селезёнка;

б) малый сальник, желудок и хвостатая доля печени;

в) печёночно-желудочная связка и передняя стенка желудка;

г) малый сальник, задняя стенка желудка и желудочно-ободочная связка.

77. Что соединяет сальниковое отверстие?

а.) верхний этаж брюшной полости с нижним;

б) брюшную полость с забрюшинным пространством;

в) подпечёночную сумку с сальниковой сумкой;

г) брюшную полость с полостью малого таза.

78. Какие сосуды подходят к большой кривизне желудка?

а) верхняя брыжеечная артерия;

б) правая желудочно-сальниковая артерия;

в) селезёночная артерия;

г) левая желудочно-сальниковая артерия.

79. Откуда берёт начало левая желудочно-сальниковая артерия?

а) от левой желудочной артерии (a. gastrica sinistra);

б) от правой желудочной артерии (a. gastrica dextra);

в) от селезёночной артерии (a. lienalis);

г) от верхней брыжеечной артерии (a. mesenterica superior).

80. Куда впадают вены пищевода?

а.) в воротную вену (v. portae);

б) в непарную и полунепарную вены;

в) в левую желудочную вену (v. gastrica sinistra);

г) в нижнюю полую вену.

81. Куда обычно открывается проток поджелудочной железы?

а) в нижнюю горизонтальную часть двенадцатиперстной кишки;

б) на большом дуоденальном сосочке;

в) в печёночно-поджелудочную ампулу;

г) в сальниковую сумку.

82. Какие сосуды предлежат к задней поверхности поджелудочной

железы?

а) левая желудочная артерия;

б) правая желудочно-сальниковая артерия;

в) верхняя брыжеечная, селезёночная и нижняя брыжеечная вены;

г) воротная вена (v. portae).

83. Как лежит селезёнка по отношению к брюшине?

а.) забрюшинно;

б) полностью покрыта брюшиной;

в) ворота селезёнки не покрыты брюшиной;

г) мезоперитонеально.

84. Где проходит селезёночная артерия?

а) по заднему краю поджелудочной железы;

б) по нижнему краю поджелудочной железы;

в) по верхнему краю поджелудочной железы;

г) через паренхиму поджелудочной железы.

85. Какие сосуды отходят от селезёночной артерии?

а) левая желудочная артерия;

б) правая желудочная артерия;

в) левая желудочно-сальниковая и короткие желудочные артерии;

г) правая желудочно-сальниковая артерия.

86. Как обычно лежит жёлчный пузырь по отношению к брюшине?

а) внутрибрюшинно;

б) забрюшинно;

в) мезоперитонеально;

г) интраперитонеально.

87. Какие протоки расположены в печёночно-дуоденальной связке?

а) правый и левый печёночные протоки;

б) пузырный проток (ductus cysticus);

в) общий жёлчный проток (ductus choledochus;

г) проток поджелудочной железы (ductus pancreaticus).

88. Куда оттекает кровь из печени?

а) в нижнюю полую вену;

б) в верхнюю полую вену;

в) в селезёночную вену;

г) в верхнюю брыжеечную вену.

89. Чем ограничен правый брыжеечный синус?

а) брыжейкой сигмовидной кишки;

б) сверху поперечной ободочной кишкой и её брыжейкой;

в) справа восходящей ободочной кишкой;

г) медиально червеобразным отростком.

90. Куда обычно распространяется гной при перфоративном аппендиците?

а) в сальниковую сумку;

б) в верхний карман сальниковой сумки;

в) в правую печёночную сумку;

г) в подпечёночную сумку.

91. Как укрепляют заднюю стенку пахового канала при прямой паховой грыже?

а) по Бассини;

б) по Боброву;

в) по Спасокукоцкому;

г) по Кимбаровскому.

92. Выберите первоочередное мероприятие при ущемленной паховой грыже:

а) теплая ванна;

б) вправление грыжи;

в) срочная операция;

г) назначение анальгетиков перед вправлением грыжи .

93. По своему характеру врожденная паховая грыжа бывает:

а) скользящей;

б) прямой;

в) ущемленной;

г) косой.

94. Как лежит грыжевой мешок по отношению к паховой связке при прямой паховой грыже?

а) позади;

б) впереди;

в) под углом;

г) медиально.

95. Что предрасполагает к возникновению грыж передней брюшной стенки?

а) пожилой возраст;

б) прогрессирующее похудание;

в) заболевания, вызывающие повышение внутрибрюшного давления;

г) особенности строения брюшной стенки.

96. Что является причиной возникновения врождённой паховой грыжи?

а.) напряжение мышц брюшного пресса;

б) повышение внутриутробного давления;

в) незаращение влагалищного отростка брюшины (processus vaginalis peritonei);

г) крипторхизм.

Тема № 4

Операции на органах брюшной полости

1. Сколько футляров в составе стенки тонкой кишки?

а) один;

б) два;

в) три;

г) четыре.

2. В течение какого времени происходит срастание серозной оболочки?

а) через 12 ч;

б) через 24 ч;

в) через 36 ч;

г) через 7 сут.

3. Какая из оболочек полых органов обладает наибольшей механической прочностью?

а) серозная;

б) мышечная;

в) подслизистая;

г) слизистая.

4. В каком слое стенки полых органов брюшной полости располагаются наиболее выраженные артериальные и венозные сплетения?

а) в серозной;

б) в мышечной;

в) в подслизистой;

г) в слизистой.

5. Кто из авторов предложил соединять серозные поверхности

путем сшивания?

а) Черни;

б) Ламбер;

в) Пирогов;

г) Шмиден.

6. Какие слои захватываются в шов при наложении шва Бира-Пирогова?

а) только слизистая оболочка;

б) слизисто-подслизистый слой;

в) слизистая, подслизистая и мышечная оболочки;

г) серозная, мышечная, подслизистая оболочки.

7. В каких отделах желудочно-кишечного тракта может использоваться двухрядный шов?

а) желудок;

б) двенадцатиперстная кишка;

в) тонкая кишка;

г) толстая кишка.

8. В каком отделе желудочно- кишечного тракта применяется трехрядный шов?

а) желудок;

б) двенадцатиперстная кишка;

в) тонкая кишка;

г) толстая кишка.

9. Что такое гастростомия?

а) введение зонда в просвет желудка;

б) наложение искусственного наружного свища на желудок;

в) формирование желудочно-кишечного анастомоза;

г) удаление части желудка.

10. Какой вид свища формируется при наложении гастростомы по способу Кадера?

а) губовидный;

б) трубчатый;

в) продольный;

г) поперечный.

11. Какой вид свища формируется при наложении его по способу Топровера?

а) губовидный;

б) трубчатый;

в) продольный;

г) поперечный.

12. Какой оболочкой полого органа выстлан канал губовидного свища?

а) серозной;

б) мышечной;

в) слизистой;

г) подслизистой.

13. Какой оболочкой полого органа выстлана внутренняя поверхность трубчатого свища?

а) серозной;

б) мышечной;

в) слизистой;

г) подслизистой.

14. Какие показания для наложения свища на желудок?

а) стеноз привратника;

б) острая кишечная непроходимость;

в) неоперабельный рак пищевода и кардиального отдела желудка;

г) стеноз пищевода.

15. Какой шов рационально применять при ушивании точечных колотых ран тонкой кишки?

а) узловые серозно-мышечные;

б) по Шмидену;

в) кисетный серозно-мышечный;

г) шов Альберта.

16. Почему раны полых органов ушивают в поперечном направлении?

а) из-за удобства работы;

б) для лучшей адаптации слоев;

в) во избежание сужения просвета;

г) в силу сложившейся традиции.

17. Что необходимо сделать для предупреждения развития «порочного» круга при впередиободочном гастроэнтероанастомозе по способу Вельфлера?

а) подшить кишку ≪изоперистальтически≫;

б) сделать соустье размером более двух диаметров кишки;

в) наложить межкишечное соустье по Брауну;

г) произвести пилоропластику.

18. Какой тип анастомоза на тонкую кишку является наиболее физиологичным?

а) ≪конец в бок≫;

б) ≪бок в конец≫;

в) ≪бок в бок≫;

г) ≪конец в конец≫.

19. Что называется мобилизацией тонкой кишки?

а) пересечение брыжейки;

б) выведение кишки на переднюю брюшную стенку;

в) подшивание кишки к париетальной брюшине;

г) пересечение брыжейки кишки с предварительной перевязкой сосудов.

20. Под каким углом по отношению к длиннику кишки накладываются жомы при резекции тонкой кишки?

а) под углом 15°;

б) под углом 30°;

в) под углом 45°;

г) под углом 60°.

21. С какой целью при резекции тонкой кишки производится

рассечение ее в косом направлении (модификация Маделунга)?

а) для уменьшения интраоперационной кровопотери;

б) для увеличения поперечного сечения анастомоза;

в) для удобства наложения анастомоза;

г) для сохранения перистальтики тонкой кишки.

22. С какой целью ушивается дефект брыжейки при резекции тонкой кишки?

а) из-за опасности кровотечения;

б) для предотвращения спаечной болезни;

в) для предупреждения ущемления петли тонкой кишки;

г) для перитонизации.

23. Какая линия предварительно проводится для расчета доступа по Мак Бурнею при аппендэктомии?

а) линия, соединяющая нижние концы реберных дуг;

б) линия, соединяющая верхние передние подвздошные ости;

в) линия, соединяющая пупок и середину паховой связки;

г) линия, соединяющая пупок и правую верхнюю переднюю подвздошную

ость.

24. Почему доступ по Мак-Бурнею-Волковичу называют переменным?

а) из-за чередования острого и тупого способов разъединения тканей;

б) из-за несовпадения линии кожного разреза с линией разъединения мышцы;

в) из-за несовпадения линии кожного разреза с линией рассечения брюшины;

г) из-за последовательного разъединения мышц с различным направлением волокон тупым способом.

25. Какие варианты положения червеобразного отростка Вы знаете?

а) медиальное;

б) латеральное;

в) подпеченочное;

г) внутрипеченочное.

26. Что нужно сделать при выделении ретроцекально-забрюшинно расположенного червеобразного отростка?

а) максимально отвести слепую кишку латерально;

б) максимально отвести слепую кишку медиально;

в) произвести мобилизацию слепой кишки;

г) произвести резекцию слепой кишки.

27. В каком случае Вам придется выполнить ретроградную аппендэктомию?

а) при тазовом положении отростка;

б) при длине отростка более 10 см;

в) при фиксации отростка спайками к задней брюшной стенке;

г) при очень коротком червеобразном отростке.

28. В чем заключаются особенности, обусловливающие отличия операций на толстой кишке от операций на тонкой кишке?

а) толстая кишка имеет более толстую стенку, чем тонкая;

б) толстая кишка имеет более тонкую стенку, чем тонкая;

в) тонкая кишка имеет более инфицированное содержимое, чем толстая;

г) толстая кишка имеет более инфицированное содержимое, чем тонкая.

29. Какой шов целесообразно применять на толстой кишке?

а) однорядный;

б) двухрядный;

в) трехрядный;

г) кисетный.

30. По ходу операции наложения противоестественного заднего прохода париетальную брюшину соединяют с кожей. С какой целью производится этот этап?

а) чтобы изолировать полость брюшины;

б) чтобы изолировать слои клетчатки брюшной стенки и предотвратить

их инфицирование;

в) для фиксации;

г) для промывания полости брюшины.

31. Для чего при наложении противоестественного заднего прохода серозный покров сигмовидной кишки соединяют с париетальной брюшиной?

а) для предупреждения развития каловой флегмоны;

б) для предупреждения развития спаечной болезни;

в) для предупреждения инфицирования полости брюшины;

г) для фиксации сигмовидной кишки.

32. Выберите характеристику шва при ушивании ран тонкой кишки:

а) линия шва лежит в продольном направлении;

б) линия шва соответствует длиннику кишки;

в) положение линии шва не имеет значения, лишь бы не было сужения;

г) шов должен быть герметичным.

33. Какие доступы используют при операциях на желудке?

а) нижнесрединная лапаротомия;

б) среднесрединная лапаротомия;

в) верхнесрединная лапаротомия;

г) трансректальный разрез.

34.Как поступают с двенадцатиперстной кишкой при резекции желудка по Бильрот II?

а) соединяют с тощей кишкой;

б) соединяют с культей желудка;

в) сохраняют для пассажа пищи;

г) ушивают наглухо.

35. Что можно повредить при создании отверстия в брыжейке поперечной ободочной кишки (mesocolon transversum)?

а) общий жёлчный проток (ductus choledochus);

б) воротную вену (v. porta);

в) верхнюю брыжеечную артерию (a. mesenterica superior);

г) среднюю ободочную артерию (a. colica media).

36. Где проводят тонкую кишку при резекции желудка по Гофмейстеру-Финстереру?

а) впереди поперечной ободочной кишки;

б) впереди большого сальника;

в) позади большого сальника;

г) через брыжейку поперечной ободочной кишки.

37.Что соединяют при резекции желудка по Гофмейстеру—Финстереру?

а) культю желудка с двенадцатиперстной кишкой;

б) ушитую наглухо культю желудка с подвздошной кишкой;

в) ушитую на 2/3 культю желудка с тощей кишкой;

г) ушитую на 2/3 культю желудка с двенадцатиперстной кишкой.

38.Где перевязывают основной ствол левой желудочной артерии (a. gastrica sinistra) при резекции желудка?

а) в малом сальнике;

б) в печёночно-желудочной связке (lig. hepatogastricum);

в) в желудочно-ободочной связке (lig. gastrocolicum);

г) в желудочно-поджелудочной связке (lig. gastropancreaticum).

39. При каком способе резекции желудка сохраняется естественный пассаж пищи?

а) по Гофмейстеру—Финстереру;

б) по Бильрот I;

в) по Бильрот II;

г) по Райхля—Полиа.

40. Назовите показания для наложения противоестественного заднего прохода:

а) рак сигмовидной кишки;

б) рак желудка;

в) наложенный свищ на желудок по топроверу;

г) неоперабельный рак прямой кишки.

41. Назовите показания для гастроэнтеростомии:

а) перфоративная язва желудка;

б) перфоративная язва двенадцатиперстной кишки;

в) рак кардиального отдела желудка;

г) неоперабельный рак антрального отдела желудка.

42. Какие из перечисленных операций относятся к радикальным?

а) резекция желудка при раке;

б) резекция желудка при язвенной болезни;

в) панкреатодуоденальная резекция при раке большого дуоденального (фатерова) сосочка;

г) гастростомия при раке пищевода.

43. Какие из перечисленных операций на толстой кишке относятся к радикальным?

а) создание межкишечного анастомоза;

б) наложение кишечной стомы при опухолях;

в) гемиколэктомия;

г) резекция поперечной ободочной кишки.

44. Какую артерию можно повредить при выполнении задней позадиободочной гастроэнтеростомии?

а) селезёночную артерию (a. lienalis);

б) левую желудочную артерию (a. gastrica sinistra);

в) среднюю ободочную артерию (a. colica media);

г) собственную печёночную артерию (a. hepatica propria).

45. Какие виды гастроэнтеростомии Вам известны?

а) передняя впередиободочная гастроэнтеростомия;

б) задняя позадиободочная гастроэнтеростомия;

в) гастроэнтеростомия при раке пищевода;

г) гастроэнтеростомия при опухоли кардиального отдела желудка.

46. Выберите показание для удаления селезёнки:

а) разрыв селезёнки, который невозможно ушить;

б) спленомегалия;

в) эхинококковые кисты;

г) рак большого дуоденального сосочка.

47. Где перевязывают селезёночные сосуды при спленэктомии?

а) в печёночно-желудочной связке;

б) в желудочно-поджелудочной связке;

в) в желудочно-селезёночной связке;

г) в сальниковой сумке.

48. Какие способы закрытия ран печени Вы знаете?

а) шов Кузнецова—Пенского;

б) пластика ран печени сальником;

в) использование гемостатических плёнок;

г) шов по Альберту.

49. Выберите показание к холецистостомии:

а) наличие воспалительного процесса в жёлчном пузыре;

б) калькулёзный холецистит при тяжёлом общем состоянии пациентов,

не позволяющем произвести холецистэктомию;

в) ранение стенки пузыря;

г) камни в общем жёлчном протоке.

50. Назовите доступы к печени и жёлчным путям:

а) доступ Федорова;

б) доступ Курвуазъе—Кохера;

в) доступ Рио-Бранко;

г) доступ Пфанненштиля.

51. Какие виды аппендэктомий Вы знаете?

а) из левостороннего доступа;

б) из нижнесрединной лапаротомии;

в) обычная аппендэктомия;

г) ретроградная аппендэктомия.

Тема № 5

Топография поясничной области и забрюшинного пространства.

Операции на органах забрюшинного пространства

1. Что является границами поясничной области?

а) XII ребро;

б) пограничная линия таза;

в) гребень подвздошной кости;

г) продолжение книзу средней подмышечной линии.

2. Чем ограничена полость живота?

а) париетальным листком брюшины;

б) внутрибрюшной фасцией;

в) большим и малым сальником;

г) забрюшинной фасцией.

3. Какие элементы образуют поясничный треугольник?

а) наружная косая мышца живота;

б) внутренняя косая мышца живота;

в) широчайшая мышца спины;

г) подвздошный гребень.

4. Какие элементы образуют стороны ромба Лесгафта —

Грюнфельда?

а) наружная косая мышца живота;

б) внутренняя косая мышца живота;

в) поперечная мышца живота;

г) мышца-разгибатель спины.

5. Какое практическое значение имеют поясничный треугольник

Пти и ромб Лесгафта — Грюнфельда?

а) места выхода грыж;

б) места выхода гнойников из забрюшинного пространства;

в) места для выполнения доступов к органам забрюшинного

пространства;

г) места для выполнения пункций и блокад.

6.Что является передней и задней границами забрюшинного

пространства?

а) париетальная брюшина;

б) внутрибрюшная фасция;

в) мышцы поясничной области;

г) фасция Тольдта.

7. Какие слои клетчатки различают в забрюшинном пространстве?

а) околопочечная;

б) межмышечная;

в) околомочеточниковая;

г) околоободочная.

8. Соединяется ли непосредственно околопочечная клетчатка с околомочеточниковой клетчаткой?

а) да, соединяется непосредственно во всех случаях;

б) нет, не соединяется;

в) соединяется очень часто;

г) соединяется крайне редко.

9. В каком направлении открыт угол, образованный продольными осями обеих почек?

а) книзу;

б) кверху;

в) латерально;

г) медиально.

10.Через какое отверстие происходит переход из грудной полости в забрюшинное пространство симпатического ствола?

а) через отверстие нижней полой вены;

б) через аортальное отверстие;

в) через щель в латеральной части ножки поясничной части диафрагмы;

г) через пищеводное отверстие.

11. На какие группы подразделяются ветви брюшной аорты?

а) на латеральные и медиальные;

б) на верхние и нижние;

в) на передние и задние;

г) на пристеночные и висцеральные.

12.Через какое отверстие диафрагмы грудной проток переходит из забрюшинного пространства в грудную полость?

а) через пищеводное отверстие;

б) через аортальное отверстие;

в) через отверстие нижней полой вены;

г) через сухожильный центр.

13. Как называется расширение в начальной части грудного протока?

а) cisterna chyli;

б) цистерна Груббера;

в) цистерна Н. И. Пирогова;

г) цистерна В. Н. Шевкуненко.

14. Грудной проток формируется обычно путем слияния:

а) правого и левого поясничных стволов;

б) диафрагмального ствола;

в) кишечного ствола;

г) тазового ствола.

15. Какой нерв прилежит к брюшному отделу мочеточника?

а) подвздошно-паховый;

б) бедренно-половой;

в) подвздошно-подчревный;

г) бедренный.

16. Чем характеризуются доступы к почке по Бергману—Израэлю или Федорову?

а) это внебрюшинные доступы;

б) это чрезбрюшинные доступы;

в) при этих доступах обязательно резецируется XII ребро;

г) это переменные доступы.

17. К какому отделу почки чаще подходит добавочная артерия?

а) верхнему полюсу;

б) передней поверхности;

в) нижнему полюсу;

г) наружному краю.

18. На каком уровне следует перевязывать мочеточник при нефрэктомии?

а) как можно ближе к лоханке;

б) как можно ближе к мочевому пузырю;

в) на середине длины между почкой и мочевым пузырем;

г) отступя не менее 5 см от нижнего конца почки.

19. Где находится точка вкола иглы при выполнении паранефральной блокады?

а) по середине нижнего края XII ребра;

б) на границе наружной 1/3 и внутренних 2/3 нижнего края XII ребра;

в) в углу между XII ребром и наружным краем мышцы, выпрямляющей позвоночник;

г) в точке наибольшей болезненности в поясничной области.

20. Что является критерием попадания конца иглы в околопочечную клетчатку при паранефральной блокаде?

а) появление крови в шприце;

б) появление ≪отрицательного мениска≫ жидкости в канюле иглы;

в) ощущение ≪провала≫;

г) появление выраженного сопротивления продвижению иглы.

21. Что проходит через поясничный четырёхугольник (четырёхугольник Лесгафта-Грюнфельда, tetragonum lumbale)?

а) подвздошно-паховый (n. ilioinguinalis) и подвздошно-подчревный (п. iliohipogastricus) нервы;

б) поверхностная артерия, огибающая подвздошную кость (a. circumflexa ilium superficialis);

в) нижняя диафрагмальная артерия (a. phrenica inferior);

г) подреберные артерия, вена и нерв (a. v. et п. subcostalis).

22. Куда может перейти воспаление при поражении забрюшинного клетчаточного пространства (textus cellulosus retroperitonealis) ?

а) в печёночную сумку;

б) в сальниковую сумку;

в) в позадипрямокишечное пространство;

г) в клетчатку поддиафрагмального пространства.

23. Какое клетчаточное пространство ограничивают листки почечной фасцин?

а) околоободочную клетчатку (paracolon) и жировую капсулу почки;

б) забрюшинное клетчаточное пространство (textus cellulosus retroperitonealis);

в) жировую капсулу почки и забрюшинное клетчаточное пространство (textus cellulosus retroperitonealis);

г) жировую капсулу почки и околомочеточниковую клетчатку (paraureterícum).

24. Куда переходит почечная фасция (fascia renalis)?

а) вплетается во влагалище крупных сосудов;

б) теряется в клетчатке поддиафрагмального пространства;

в) теряется в клетчатке малого таза;

г) в предбрюшинную клетчатку.

25. Что расположено впереди започечной фасции (fascia retrorenalis)?

а) почки, надпочечники и мочеточники;

б) почка, аорта и надпочечники;

в) лимфатические узлы, грудной проток и надпочечники;

г) восходящая ободочная и нисходящая ободочная кишки.

26. Назовите оболочки почки:

а) забрюшинное клетчаточное пространство (textus cellulosus retroperitonealis);

б) фиброзная капсула (capsula fibrosa renis);

в) жировая капсула (capsula adiposa renis);

г) околоободочная клетчатка (paracolon).

27. Что расположено кзади от почек?

а) поясничная часть диафрагмы;

б) квадратная мышца поясницы;

в) поперечная мышца живота;

г) тела liii-liv.

28. Что прилегает со стороны брюшной полости к правой почке?

а) печень и нисходящая часть двенадцатиперстной кишки;

б) восходящая ободочная кишка;

в) левый изгиб ободочной кишки;

г) горизонтальная часть двенадцатиперстной кишки.

29. Что прилегает со стороны брюшной полости к левой почке?

а) желудок и хвост поджелудочной железы;

б) тело поджелудочной железы и восходящая часть двенадцатиперстной кишки;

в) селезёнка, левый изгиб ободочной кишки и пристеночная брюшина левого бокового канала;

г) печень и тело поджелудочной железы.

30. Куда впадают почечные вены?

а) в воротную вену;

б) в нижнюю полую вену;

в) в верхнюю брыжеечную вену (v. mesenterica inferior);

г) в верхнюю полую вену.

31.Что прилегает к правому надпочечнику?

а) почка;

б) диафрагма;

в) головка поджелудочной железы;

г) нижняя полая вена.

32.Что прилегает к левому надпочечнику?

а) хвост поджелудочной железы;

б) селезёночные сосуды;

в) диафрагма и желудок;

г) большой сальник.

33. Сколько сужений у мочеточника?

а) одно;

б) два;

в) три;

г) четыре.

34. Где находится проекция мочеточника на переднюю брюшную стенку?

а.) по наружному краю прямой мышцы живота;

б) по внутреннему краю прямой мышцы живота;

в) параректально;

г) на 2 см кнаружи от латерального края прямой мышцы живота (m. rectus abdominis).

35. Какие сосуды пересекает мочеточник в области пограничной линии (linea terminalis)?

а) правую общую подвздошную артерию (a. iliaca communis dextra);

б) правую наружную подвздошную артерию (a. iliaca extema dextra);

в) левую общую подвздошную артерию (a. iliaca communis sinistra);

г) левую наружную подвздошную артерию (a. iliaca extema sinistra).

36. Что лежит кпереди от брюшной аорты?

а) поджелудочная железа;

б) правая почечная вена;

в) корень брыжейки тонкой кишки;

г) левая почечная вена.

37. Где лежит чревное сплетение?

а) окружает чревный ствол (truncus coeliacus);

б) окружает аорту;

в) на задней поверхности аорты;

г) на передней поверхности грудных позвонков.

38. Где проходит бедренный нерв (n. femoralis)?

а) в толще большой поясничной мышцы и квадратной мышцы поясницы;

б) между подвздошной (m. iliacus) и большой поясничной (m. psoas major) мышцами;

в) между большой и малой поясничными мышцами (m. psoas major et minor);

г) между квадратной мышцей поясницы (m. quadratus lumborum) и боль шой поясничной мышцей (m. psoas major).

39. Где проходит бедренно-половой нерв (n. genitofemoralis)?

а) прободает фасцию и лежит на передней поверхности большой поясничной мышцы (т. psoas major);

б) на задней поверхности большой поясничной мышцы (m. psoas major);

в) между большой и малой поясничными мышцами (m. psoas major et minor);

г) между поясничной фасцией (fascia psoatis) и брюшиной.

40. Укажите, на уровне какого ребра от латерального края мышцы, выпрямляющей позвоночник, начинается разрез по Федорову?

а) угол XI ребра;

б) середина XI ребра;

в) середина XII ребра;

г) свободный край XII ребра.

41. Какую пиелотомию следует считать топографоанатомически более обоснованной?

а) переднюю;

б) заднюю.

42. Укажите, какой сосуд пересекает конечный отдел пристеночной части мочеточника вблизи боковой стенки таза у женщин?

а) внутренняя подвздошная артерия;

б) наружная подвздошная артерия;

в) уретральная артерия;

г) маточная артерия.

43. От какого сосуда отходят артерии к верхнему отделу мочеточника?

а) верхняя прямокишечная артерия;

б) почечная артерия;

в) яичковая (яичниковая) артерия;

г) общая подвздошная артерия.

44. От каких сосудов отходят артерии к среднему отделу мочеточника?

а) почечная артерия;

б) яичковая (яичниковая) артерия;

в) брюшная аорта;

г) внутренняя подвздошная артерия.

45. Какова последовательность выделения почки из жировой ткани при нефрэктомии?

а) верхний полюс, передняя поверхность, нижний полюс, задняя поверхность;

б) задняя поверхность, верхний полюс, передняя поверхность, нижний полюс;

в) задняя поверхность, нижний полюс, передняя поверхность, верхний полюс;

г) передняя поверхность, верхний полюс, задняя поверхность, нижний полюс.

46. К чему фиксируют почку при нефроптозе и какой капсулой?

а) к поясничным позвонкам фиброзной капсулы почки;

б) к 12 ребру всеми капсулами почки;

в) к 12 ребру фиброзной капсулы почки;

г) к 12 ребру фасциями почки.

47. Укажите, какие анатомические образования служат ориентирами при осуществлении доступа к мочеточнику по Пирогову?

а) наружная косая мышца живота;

б) паховая связка;

в) пирамидальная мышца;

г) лобковая кость.

48. При ушивании разреза стенки мочеточника захватывается в шов слизистая или нет?

а) да;

б) нет.

49. Почему нельзя выделять мочеточник на большом протяжении?

а) это приведет к перегибу мочеточника и нарушению оттока мочи;

б) это приведет к стенозу мочеточника;

в) это приводит к нарушению его кровоснабжения, что вызовет некроз мочеточника.

Тема № 6

Топография и операции на органах малого таза

1. Какими элементами ограничен таз как часть тела человека?

а) тазовыми костями;

б) крестцом;

в) копчиком;

г) бедренными костями.

2. Какая плоскость разделяет большой и малый таз?

а) плоскость на уровне пограничной линии;

б) плоскость, проходящая через нижний край лобкового симфиза;

в) плоскость, пересекающая седалищные бугры;

г) плоскость, проведенная через подвздошный гребень.

3. Какие мышцы образуют диафрагму таза?

а) m. coccygeus;

б) m. levator ani;

в) m. transversus perinei profundus;

г) m. transversus perinei superficialis.

4. Какую артерию пересекает правый мочеточник при переходе в тазовый отдел?

а) внутреннюю подвздошную;

б) общую подвздошную;

в) наружную подвздошную;

г) копчиковую.

5. Какую артерию пересекает мочеточник в околоматочном

простанстве?

а) внутреннюю подвздошную;

б) маточную;

в) яичниковую;

г) наружную подвздошную.

6. На какие отделы подразделяются клетчаточные пространства

таза?

а) на поверхностные и глубокие;

б) на пристеночные и висцеральные;

в) на передний и задний;

г) на латеральные и медиальные.

7. Какие клетчаточные пространства можно выделить в

подбрюшинном этаже таза?

а) позадилобковое (предпузырное) клетчаточное;

б) околопузырное;

в) позадипрямокишечное;

г) пристеночное клетчаточное.

8. Следует ли захватывать слизистую оболочку при наложении

швов на стенку мочевого пузыря?

а) да, захватывается обязательно;

б) не захватывается ни в коем случае;

в) слизистая оболочка включается в шов только при значительной

величиине дефекта стенки мочевого пузыря;

г) слизистая не захватывается в шов только при ликвидации дефектов,

локализующихся у верхушки мочевого пузыря.

9. Какие условия соблюдаются при восстановлении целости

мочеточника с помощью анастомоза «конец в конец»?

а) слизистая оболочка в шов не включается;

б) концы мочеточника иссекаются под углом 45о;

в) для наложения швов применяется кетгут;

г) шов накладывается на всю толщу стенки мочеточника.

10. В какой части мочеточника чаще всего застревают мочевые камни?

а) в местах сужений;

б) в местах расширений;

в) в любом месте мочеточника.

11. На каком уровне проходит мочеточник в широкой связке матки?

а) в верхней части связки;

б) на середине высоты связки;

в) на границе верхней и средней третей высоты связки;

г) в основании широкой связки матки.

12.Через какой канал проходит круглая связка матки?

а) через запирательный канал;

б) через бедренный канал;

в) через паховый канал;

г) через пудендальный канал (канал Алькокка).

13. Какие элементы образуют стенки седалищно-прямокишечной ямки?

а) мышца, поднимающая задний проход;

б) седалищная кость;

в) подвздошная кость;

г) кожа промежности.

14. Сколько отделов имеет околопрямокишечная клетчатка?

а) один отдел;

б) два отдела — правый и левый;

в) четыре отдела (передний и задний, правый и левый);

г) три отдела (передний правый, передний левый и задний).

15. Как должна проводиться игла при пункции Дугласова

пространства через заднюю часть свода влагалища?

а) в сагиттальной плоскости;

б) строго горизонтально;

в) снизу вверх;

г) сверху вниз.

16. Какие ветви относятся к основным висцеральным ветвям внутренней подвздошной артерии?

а) нижние мочепузырные артерии;

б) маточные артерии;

в) средние прямокишечные артерии;

г) запирательные артерии.

17. Какие сосуды относятся к париетальным ветвям внутренней подвздошной артерии?

а) средние прямокишечные артерии;

б) латеральная крестцовая артерия;

в) верхняя ягодичная артерия;

г) нижняя ягодичная артерия.

18. Какие операции выполняются обычно при водянке яичка?

а) по Вассерману;

б) по Бергману;

в) по Бассини;

г) по Винкельману.

19. На какие группы делятся вены таза?

а) на передние и задние;

б) на париетальные и висцеральные;

в) на поверхностные и глубокие;

г) на наружные и внутренние.

20. Какими особенностями характеризуются вены таза?

а) крупным калибром;

б) выраженностью клапанного аппарата;

в) фиксацией стенок вены к стенкам таза;

г) большим количеством анастомозов с другими венами таза и венами близлежащих областей.

21. На каком уровне при слиянии общих подвздошных вен образуется нижняя полая вена?

а) на уровне мыса;

б) на уровне IV-V поясничных позвонков;

в) на уровне III поясничного позвонк;

г) на середине длины крестца.

22. Какое углубление является самым глубоким отделом брюшной полости?

а) пузырно-маточное;

б) прямокишечно-маточное.

23. Какие оперативные доступы применяются при операции простатэктомии по поводу аденомы предстательной железы?

а) чрезпромежностный;

б) параректальный;

в) трансуретральный;

г) чрезпузырный

24. Какая операция по поводу операбельного рака прямой кишки выполняется при локализации опухоли ниже 6 см от заднепроходного отверстия?

а) брюшно-анальная резекция с низведением сигмовидной кишки;

б) сигмостомия;

в) передняя резекция с наложением анастомоза конец в конец;

г) брюшно-промежностная экстирпация.

25. Какая операция по поводу операбельного рака прямой кишки выполняется при локализации опухоли выше 12 см от заднепроходного отверстия?

а) передняя резекция или резекция ректо-сигмоидного отдела с наложениием анастомоза конец в конец;

б) брюшно-промежностная экстирпация;

в) брюшно-анальная резекция с низведением сигмовидной кишки;

г) сигмостомия.

26. Какой вид операции гемороидэктомии наиболее распространен?

а) по Мартынову;

б) по Винкельману;

в) по Миллигану-Моргану;

г) по Габриелю.

27. Какие группы лимфатических узлов выделяют в малом тазу?

а) по ходу наружной и внутренней подвздошной артерий;

б) по ходу внутренней подвздошной артерии;

в) по ходу общей и наружной подвздошной артерии;

г) на передней поверхности крестца.

28. С какой целью и по каким показаниям может осуществляться цистотомия?

а) удаление инородных тел, мочевых камней;

б) для пункции брюшной полости через заднюю стенку мочевого пузыря;

в) как оперативный доступ про операции простатэктомии;

г) с целью эвакуации мочи при невозможности катетеризации мочеиспускательного канала, тогда операция завершается цистостомией.

29. Укажите мышцы, покрывающие стенки малого таза.

а) грушевидная мышца (т. piriformis);

б) наружная запирательная (т. obturatprius extemus) и грушевидная (т.piriformis) мышцы;

в) внутренняя запирательная мышца (т. obturatorius internus);

г) внутренняя запирательная (т. obturatorius internus) и верхняя близнецовая (т. gemelus superior) мышцы.

30. Чем образованы большое и малое седалищные отверстия?

а) крестцрво-остистой и крестцово-бугорной связками (lig. sacrospinale et lig. sacrotuberale);

б) лобково-крестцовой и крестцово-остистой связками (lig. pubosacrale

et lig. Sacrospinale;.

в) седалищно-бедренной связкой (lig. ischiofemorale);

г) большой седалищной вырезкой (incisura ischiadica major).

31. Где начинается грушевидная мышца (m. piriformis)?

а) от крыльев подвздошной кости (ala ossis ilii);

б) от передней поверхности крестца (facies pelvina);

в) от дугообразной линии подвздошной кости (linea arcuata ossis ilii);

г) от межвертельной линии (linea intertrochanterica).

32. Где начинается мышца, поднимающая задний проход (m. levator ani)?

а) от брюшно-промежностной фасции;

б) от сухожильной дуги фасции таза;

в) от крыльев подвздошной кости;

г) от большой седалищной вырезки.

33. Где открываются протоки бартолиновых желёз?

а) на внутренней поверхности малых половых губ;

б) на внутренней поверхности больших половых губ;

в) в преддверии влагалища;

г) в области клитора.

34.Что проходит через мочеполовую диафрагму у женщин?

а) мочеиспускательный канал; б) влагалише и заднепроходный канал;

в) влагалище;

г) внутренняя половая артерия.

35. Продолжением чего является фасция таза ?

а) запирательной фасции;

б) внутренностной фасции живота;

в) апоневроза наружной косой мышцы живота;

г) влагалища и заднепроходного канал.

36.Что находится в полости таза спереди от прямокишечно-пузырной перегородки (у мужчин)?

а) мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки и

ампулы семявыносящих протоков;

б) мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки и семявыносящий проток;

в) предстательная железа, прямая киша и мочеточник;

г) семенные пузырьки, мочевой пузырь и предстательная железа.

37.Что находится в полости таза сзади от прямокншечно-маточной перегородки (у женщин)?

а) матка и прямая кишка;

б) прямая кишка;

в) задний свод влагалища, влагалищная часть шейки матки и прямая кишка;

г) мочевой пузырь и прямая кишка.

38. Сколько этажей выделяют в полости малого таза?

а) два;

б) один;

в) три;

г) пять.

39. Каковы границы брюшной полости таза?

а) вход в малый таз и брюшина;

б) тазовая фасция и вход в малый таз;

в) гребень подвздошной кости, лонное сочленение и брюшина;

г) фасция, покрывающая мышцу, поднимающую задний проход, и брюшина.

40.Через какую мышцу проходит влагалище?

а) через мышцу, поднимающую задний проход;

б) через глубокую поперечную мышцу промежности;

в) через копчиковую мышцу;

г) через поверхностную поперечную мышцу промежности.

41. Какие сосуды и нервы расположены в подбрюшинной полости таза?

а) внутренняя подвздошная артерия с её ветвями;

б) наружная подвздошная артерия;

в) крестцовое сплетение с нервами;

г) чревное сплетение.

42. Где расположена подкожная полость таза?

а) между диафрагмой таза и брюшиной;

б) между брюшиной и входом в малый таз;

в) между диафрагмой таза и кожей;

г) между поверхностной и глубокой поперечными мышцами промежности и кожей.

43. Как расположены но отношению к внутренней подвздошной артерии одноимённые вены?

а) кпереди от артерии;

б) кнутри от артерии;

в) кзади от артерии;

г) кнаружи от артерии.

44. Где расположено крестцовое сплетение?

а) на нижней близнецовой мышце;

б) на внутренней поверхности крестца;

в) на грушевидной мышце;

г) на крыльях подвздошной кости.

45. Через какое образование проходит верхний ягодичный нерв (n. gluteus superior) ?

а) через запирательное отверстие (foramen obturatorium);

б) через подгрушевидное отверстие (foramen infrapiriforme);

в) через надгрушевидное отверстие (foramen suprapiriforme);

г) через большое седалищное отверстие (foramen ischiadicum major).

46. Где расположено крестцовое сплетение?

а) кнутри от передних крестцовых отверстий;

б) спереди от передних крестцовых отверстий;

в) кнаружи от передних крестцовых отверстий;

г) на дорсальной поверхности крестца.

47. Сколько отделов выделяют в маточной трубе?

а)не имеет отделов;

б) один;

в) два;

г) четыре.

48. Сколько основных связок у яичника?

а)одна;

б) две;

в) не имеет связок;

г) три.

49. Где расположены яичники в малом тазу?

а) в области бифуркации общей подвздошной артерии;

б) в области подвздошной ямки;

в) у бахромок маточных труб;

г) на передней поверхности широкой связки матки.

50. Из каких корешков образуется крестцовое сплетение?

а) 4-5 поясничных, 1-3 крестцовых;

б) 3-5 поясничных, 1-2 крестцовых;

в) v поясничного, 1—3 крестцовых;

г) 1—4 крестцовых.

51. Что расположено спереди от прямой кишки у женщин?

а) задняя стенка влагалища;

б) задний свод влагалища;

в) тело матки;

г) задняя стенка шейки матки.

52. Что прилегает к мочевому пузырю у женщин?

а) сзади — влагалище, тело и дно матки;

б) спереди — лобковый симфиз;

в)сверху — брюшина;

г) с боков — копчиковая мышца.

53.Сколько клетчаточных пространств расположено впереди

мочевого пузыря?

а) одно;

б) два;

в) нет клетчаточных пространств;

г) три.

54. Что расположено в позадипрямокишечном клетчаточном

пространстве?

а) верхняя и нижняя крестцовые артерии;

б) венозное сплетение;

в) симпатические нервы;

г) внутренние подвздошные сосуды.

55. Где расположено параметральное пространство?

а) сбоку от шейки матки и между листками широкой связки матки;

б) между листками широкой связки матки;

в) между маточными трубами и боковой стенкой малого таза;

г) вокруг шейки матки.

56. Сколько артерий кровоснабжает прямую кишку?

а) три;

б) две;

в) одна;

г) пять.

57. Сколько отделов выделяют в прямой кишке?

а) три (надампулярная часть, ампула и заднепроходной канал);

б) два (тазовый и промежностный);

в) не имеет отделов;

г) три (соответственно изгибам).

58. Что лежит спереди от прямой кишки у мужчин?

а) мочевой пузырь, мочеиспускательный канал и простата;

б) задний свод влагалища и мочевой пузырь;

в) предстательная железа, мочевой пузырь, ампулы семявыносящих

протоков, семенные пузырьки и мочеточники;

г) мочеиспускательный канал и мочевой пузырь.

59. Что проходит в подвешивающей связке яичка?

а) маточная артерия;

б) яичниковые артерия и вена;

в) верхняя мочепузырная артерия;

г) яичниковая артерия и маточная вена.

60. За счёт чего осуществляется вегетативная иннервация прямой кишки?

а) за счёт верхнего прямокишечного сплетения;

б) за счёт правого подчревного нерва;

в) за счёт левого подчревного нерва;

г) за счёт крестцового сплетения.

61. Укажите границы промежности;

а) передняя — нижние ветви лонных и седалищных костей;

б) наружная — седалищные бугры;

в) задняя — копчик и крестец;

г) верхняя — крылья подвздошной кости.

62. Что расположено в поверхностных отделах промежности?

а) бульбоуретральные железы;

б) наружный сфинктер заднего прохода и поверхностная поперечная мышца промежности;

в) дорсальные вена и нерв полового члена;

г) седалищно-пещеристая и луковично-губчатая мышцы.

63. Куда происходит лимфоотток от поверхностных отделов промежности?

а) в лимфатические узлы по ходу внутренней половой артерии;

б) в запирательные лимфатические узлы;

в) в паховые лимфатические узлы;

г) в лимфатические узлы крестцовой области.

64. Где проходит главная связка матки?

а) по ходу яичниковой артерии;

б) вдоль маточных сосудов;

в) в брыжейке маточных труб;

г) в брыжейке яичника.

65. Где расположен сухожильный центр промежности?

а) но лобково-крестцовой линии;

б) на середине линии, соединяющей седалищные бугры;

в) между прямой кишкой и мочевым пузырём;

г) между мочеиспускательным каналом и влагалищем.

66. Какие образования прикрепляются к сухожильному центру промежности?

а) спереди — луковично-пещеристая мышца;

б) сзади — внутренний сфинктер заднего прохода;

в) с боков — поверхностная поперечная мышца промежности;

г) сверху — брюшно-промежностный апоневроз.

67. Куда открываются бульбоуретральные железы?

а.) в пешеристую внелуковичную часть мочеиспускательного канала;

б) в перепончатую часть мочеиспускательного канала;

в) в проксимальный отдел губчатой части мочеиспускательного канала;

г) в предстательную часть мочеиспускательного канала.

68. Что проходит в половом канале?

а) верхняя прямокишечная артерия;

б) седалищный нерв;

в) внутренние половые артерия, вена и половой нерв;

г) запирательный нерв.

69. Какие кавернозные тела различают в половом члене?

а.) два пещеристых тела;

б) пещеристое тело;

в) губчатое тело;

г) два губчатых и одно пещеристое тела.

70. За счёт чего образуется луковица полового члена?

а) за счёт переднего отдела губчатого тела полового члена;

б) за счёт заднего отдела пещеристого тела полового члена;

в) за счёт заднего отдела губчатого тела полового члена;

г) за счёт переднего отдела пещеристого тела полового члена.

71. Где проходит глубокая дорсальная вена полового члена?

а) между кожей и фасцией полового члена;

б) между белочной оболочкой и пещеристыми телами;

в) между фасцией и белочной оболочкой;

г) между пещеристыми телами.

72. Сколько отделов выделяют в мочеиспускательном канале у мужчин?

а) один;

б) четыре;

в) три;

г) два.

73. Что открывается в предстательную часть мочеиспускательного канала?

а) семявыбрасывающий проток;

б) семявыносящие протоки;

в) предстательная железа;

г) семявыносящие и семявыбрасывающие протоки.

74. Сколько сужений и расширений выделяют в мужском мочеиспускательном канале?

а) три сужения и два расширения;

б) два сужения и одно расширение;

в) три сужения и три расширения;

г) не имеет сужений и расширений.

75. Сколько искривлений выделяют в мужском мочеиспускательном канале?

а) одно;

б) два;

в) три;

г) четыре.

76. Каковы показания к дренированию предпузырного пространства?

а) мочевые затёки;

б) камни мочевого пузыря;

в) флегмона предпузырной клетчатки, развившаяся в результате ранения мочевого пузыря;

г) перитонит.

77. Назовите этапы цистотомии:

а) предварительное пересечение вен;

б) прокол стенки мочевого пузыря между лигатурами;

в) продольный разрез мышечной стенки;

г) рассечение слизистой оболочки.

78. Каковы показания к проколу мочевого пузыря?

а) невозможность катетеризации мочевого пузыря;

б) гнойный цистит;

в) камни мочевого пузыря;

г) повреждение прямой кишки.

79. Выберите определение варикоцеле:

а) расширение вен прямой кишки;

б) расширение вен яичка;

в) сужение и стеноз вен семенного канатика;

г) расширение вен семенного канатика.

80. Каной разрез слизистой оболочки проводят при субмукозной геморроидэктомии по Миллигану-Моргану?

а) элипсовидный с рассечением слизистой оболочки в центре;

б) овальный;

в) полукруглый;

г) круговой.

81. Какие формы геморроя выделяют?

а) наружный и комбинированный;

б) наружный, внутренний и комбинированный;

в) косой, прямой и смешанный;

г) смешанный, нижний и верхний.

Тема № 7

Топография верхней и нижней конечностей

1. Какими мышцами образована передняя стенка подмышечной впадины?

а) большой грудной и подключичной мышцами;

б) большой грудной и малой грудной мышцами;

в) малой грудной и медиальной поверхностью плечевой кости;

г) длинной головкой двуглавой мышцы плеча и малой грудной мышцей.

2. Чем образована латеральная стенка четырехстороннего отверстия?

а) длинной головкой трехглавой мышцы плеча;

б) хирургической шейкой плечевой кости;

в) малой круглой мышцей;

г) подлопаточной мышцей.

3. Как располагается подмышечная вена по отношению к соответствующей артерии на протяжении подмышечной области?

а) вена лежит кпереди и медиально;

б) вена лежит кпереди и латерально;

в) вена лежит кпереди;

г) вена лежит кзади.

4. Как располагаются пучки плечевого сплетения по отношению к подмышечной артерии в tr. pectorale?

а) спереди, сзади и латерально;

б) спереди, сзади и медиально;

в) латерально, медиально и сзади;

г) только спереди и сзади.

5. Как формируется срединный нерв в подмышечной впадине?

а) из латерального пучка плечевого сплетения;

б) из медиального пучка плечевого сплетения;

в) из элементов латерального и медиального пучков;

г) из элементов латерального и заднего пучков.

6. Из какого пучка плечевого сплетения формируется лучевой нерв?

а) из латерального;

б) из медиального;

в) из заднего и медиального;

г) из заднего.

7. Как формируется подмышечный нерв в подмышечной области?

а) из латерального пучка;

б) из медиального пучка;

в) из заднего пучка;

г) из заднего и латерального пучков.

8. Как формируется мышечно-кожный нерв в подмышечной

области?

а) из медиального пучка;

б) из латерального пучка;

в) из заднего пучка;

г) из латерального и медиального пучков.

9. Где можно определить пульсацию плечевой артерии?

а) у наружного края двуглавой мышцы плеча;

б) у места прикрепления к плечевой кости дельтовидной мьшцы;

в) у внутреннего края дельтовидной мышцы;

г) на середине медиальной поверхности плеча.

10. Как располагается срединный нерв по отношению к плечевой

артерии в верхней трети плеча?

а) спереди;

б) сзади;

в) латерально;

г) медиально.

11. Как проходит срединный нерв по отношению к плечевой артерии

в нижней трети плеча?

а) спереди;

б) сзади;

в) медиально;

г) латерально.

12. Между какими мышцами располагается мышечно-кожный нерв на плече?

а) между клювовидно-плечевой и плечевой;

б) между двуглавой и плечевой;

в) между двуглавой и трехглавой;

г) между двуглавой и клювовидно-плечевой.

13. Иннервация каких мышц нарушается при повреждении мышечно-кожного нерва в подмышечной области?

а) двуглавой мышцы плеча;

б) плечевой мышцы;

в) клювовидно-плечевой мышцы;

г) трехглавой мышцы плеча.

14. Какие подкожные вены переднего отдела области локтя целесообразно выбирать для пункции во избежание повреждения кожных нервов и глубоких образований локтя?

а) v. basilica;

б) v. cephalica;

в) v. intermedia basilica;

г) v. intermedia cubiti.

15. Как располагается срединный нерв по отношению к плечевой артерии в локтевой ямке?

а) спереди;

б) сзади;

в) латеральпо;

г) медиально.

16. На какие ветви делится лучевой нерв в передней латеральной борозде локтевой ямки?

а) на поверхностную и глубокую;

б) на переднюю и медиальную;

в) на переднюю и латеральную;

г) на переднюю и заднюю.

17. Какие причины могут привести к сдавлению локтевого нерва в локтевой области?

а) гематома;

б) осложненный перелом медиального надмыщелка;

в) вывих локтевого сустава;

г) фурункул.

18. Сколько футляров для мышц образует собственная фасция предплечья в переднем отделе?

а) один;

б) два;

в) три;

г) четыре.

19. Сколько сосудисто-нервных пучков проходят в средней трети переднего отдела предплечья?

а) один;

б) два;

в) четыре;

г) три.

20. С какой стороны по отношению к лучевой артерии располагается поверхностная ветвь лучевого нерва в верхней и средней третях предплечья?

а) спереди;

б) сзади;

в) снаружи;

г) изнутри.

21. С какой стороны по отношению к локтевой артерии находится на протяжении предплечья локтевой нерв?

а) спереди;

б) сзади;

в) латерально;

г) медиально.

22. Между какими слоями мышц располагается клетчаточное пространство Пирогова?

а) первым и вторым;

б) вторым и третьим;

в) третьим и четвертым;

г) четвертым и пятым.

23. Где располагается срединный нерв в верхней трети предплечья?

а) между поверхностным и глубоким сгибателями пальцев;

б) между головками круглого пронатора;

в) между лучевым сгибателем запястья и поверхностным сгибателем пальцев;

г) между плечелучевой мышцей и поверхностным сгибателем пальцев.

24. Где проходит срединный нерв в средней трети предплечья?

а) между головками круглого пронатора;

б) между поверхностным и глубоким сгибателями пальцев;

в) между лучевым сгибателем запястья и поверхностным сгибателем пальцев;

г) между межкостной мембраной и длинным сгибателем большого пальца кисти.

25. При поражении каких синовиальных влагалищ сухожилий сгибателей пальцев гной может прорваться в клетчаточное пространство Пирогова?

а) лучевой сумки;

б) локтевой сумки;

в) лучевой и локтевой сумок;

г) прорыв гноя из синовиальных влагалищ исключен.

26. На какой поверхности предплечья делают разрезы при вскрытии

флегмоны клетчаточного пространства Пирогова?

а) на передней;

б) на задней;

в) на латеральной;

г) на боковых поверхностях предплечья.

27. Какие борозды различают в нижней трети предплечья?

а) лучевая;

б) локтевая;

в) срединная;

г) борозда локтевого нерва.

28. Что располагается в срединной борозде в нижней трети

предплечья?

а) лучевая артерия;

б) локтевая артерия и локтевой нерв;

в) срединный нерв;

г) передний межкостный нерв и передняя межкостная артерия.

29. Что проходит в лучевом канале запястья?

а) лучевая артерия;

б) поверхностная ветвь лучевого нерва;

в) сухожилие лучевого сгибателя запястья;

г) срединный нерв.

30. Сколько сухожилий проходит в канале запястья?

а) одно;

б) три;

в) шесть;

г) девять.

31. Чем обусловлена необходимость выделения «запретной зоны» в

проксимальном отделе thenar?

а) повреждение сухожилий сгибателей пальцев;

б) повреждение сухожилия длинного сгибателя большого пальца кисти;

в) повреждение двигательной ветви срединного нерва с нарушением про

тивопоставления большого пальца;

г) повреждение поверхностной артериальной ладонной дуги.

32. Где расположены дистальные границы синовиальных влагалищ сухожилий сгибателей II-IV пальцев?

а) на уровне основания дистальной фаланги пальцев;

б) на уровне середины средних фаланг пальцев;

в) у дистального конца ногтевых фаланг пальцев;

г) на уровне головок пястных костей.

33. Что содержит среднее фасциальное ложе ладони?

а) сухожилия поверхностных и глубоких сгибателей II-V пальцев;

б) червеобразные мышцы;

в) поверхностную артериальную ладонную дугу;

г) все вышеперечисленные элементы.

34. Что такое V- образная флегмона?

а) гнойный тендовагинит I и V пальцев;

б) гнойный тендовагинит II и IV пальцев;

в) гнойный тендовагинит II и III пальцев;

г) гнойное поражение межмышечных промежутков возвышения I и V пальцев.

35. Чем объясняется необходимость срочного оперативного вмешательства при гнойном тендовагините сухожилий сгибателей пальцев?

а) опасностью распространения гноя в клетчаточное пространство Пирогова;

б) опасностью перехода процесса на костные ткани;

в) опасностью омертвения сухожилий вследствие сдавления их брыжейки;

г) опасностью развития сепсиса.

36. Где следует делать разрезы на пальцах кисти при гнойном тендовагините?

а) на ладонной поверхности;

б) на задней поверхности;

в) на боковых поверхностях вне межфаланговых суставов;

г) в области ногтевой фаланги.

37. Какие нервы проходят в подкожной клетчатке

переднелатеральной и переднемедиальной поверхностей бедра?

а) медиальный кожный нерв бедра;

б) латеральный кожный нерв бедра;

в) передний кожный нерв бедра;

г) бедренный нерв.

38. На какие отделы делится пространство под паховой связкой?

а) на грыжевую, мышечную и сосудистую лакуны;

б) на мышечную и грыжевую лакуны;

в) па грыжевую и сосудистую лакуны;

г) на мышечную и сосудистую лакуны.

39. Что является стенками бедренного канала?

а) бедренная вена, поверхностный и глубокий листки широкой фасции;

б) паховая связка, гребешковая связка и бедренная вена;

в) поверхностная фасция и бедренная вена;

г) паховая связка, гребешковая связка и поверхностный листок широкой

фасции бедра.

40. Что выходит через мышечную лакуну?

а) бедренная артерия и вена;

б) бедренный нерв;

в) бедренный нерв, артерия и вена;

г) подвздошно-поясничная мышца и бедренный нерв.

41. Что выходит через переднее отверстие приводящего канала?

а) бедренная артерия;

б) подкожный нерв;

в) подкожный нерв и нисходящая коленная артерия;

г) нисходящая коленная артерия.

42. Как располагается бедренная вена по отношению к артерии в

приводящем канале?

а) медиально;

б) латерально;

в) кзади;

г) кпереди.

43. Как располагается бедренная вена по отношению к артерии в верхней трети бедра?

а) кпереди;

б) кзади;

в) медиально;

г) латерально.

44. Сколько фасциальных футляров на бедре для различных групп мышц?

а) один;

б) два;

в) три;

г) четыре.

45. С чем сообщается клетчатка медиального отдела бедра через запирательное отверстие?

а) с околоматочным пространством;

б) боковым клетчаточным пространством малого таза;

в) с седалищно-прямокишечной ямкой;

г) с задней поверхностью бедра.

46. По какой артерии восстанавливается кровоток на нижней конечности после закупорки, повреждения или лигирования бедренной артерии в средней трети области?

а) по латеральной артерии, огибающей бедренную кость;

б) по наружной подвздошной артерии;

в) по глубокой артерии бедра;

г) по внутренней подвздошной артерии.

47. Какими мышцами образована подколенная ямка?

а) полусухожильной;

б) полуперепончатой;

в) двуглавой мышцей бедра;

г) икроножной.

48. Какие вены проходят в подкожной клетчатке заднего отдела области колена?

а) большая подкожная вена ноги;

б) малая подкожная вена ноги;

в) бедренная вена;

г) подколенная вена.

49. Какие вены нижней конечности чаще поражаются варикозной болезнью?

а) большая подкожная вена ноги;

б) малая подкожная вена ноги;

в) подколенная вена;

г) бедренная вена.

50. Сколько стенок имеет голенно-подколенный канал?

а) две;

б) три;

в) четыре;

г) канал имеет округлую форму.

51. Сколько отверстий имеет голено-подколенный канал?

а) два входных и два выходных;

б) одно входное и два выходных;

в) одно входное и три выходных;

г) два входных и три выходных.

52. Что проходит через нижний мышечно-малоберцовый канал?

а) общий малоберцовый нерв;

б) глубокий малоберцовый нерв;

в) малоберцовая артерия;

г) нисходящая коленная артерия.

53. Где проходит поверхностный малоберцовый нерв в верхней трети голени?

а) под кожей латеральной поверхности голени;

б) в верхнем мышечно-малоберцовом канале;

в) между передней большеберцовой мышцей и длинным разгибателем пальцев;

г) на межкостной мембране.

54. Как обычно располагается глубокий малоберцовый нерв по отношению к передней большеберцовой артерии в верхней трети голени?

а) спереди;

б) сзади;

в) латерально;

г) медиально.

55. Как обычно располагается глубокий малоберцовый нерв по отношению к передней большеберцовой артерии в нижней трети голени?

а) спереди;

б) сзади;

в) латерально;

г) медиально.

56. Чем обусловлена возможность механического повреждения общего малоберцового нерва на уровне головки малоберцовой кости?

а) поверхностным расположением нерва, лежащего на костном основании;

б) особенностью деления нерва на глубокую и поверхностную ветви;

в) особенностью строения нерва, связанной с недоразвитием миелиновой оболочки;

г) высокой чувствительностью нерва.

57. Какие элементы проходят в запирательном канале?

а) запирательная вена;

б) запирательный нерв;

в) запирательная артерия;

г) половой нерв.

58. Чем опасно повреждение верхней ягодичной артерии?

а) ишемией ягодичной области;

б) возможностью перемещения центрального конца артерии в полость малого таза с обильным внутренним кровотечением;

в) сдавлением образующейся гематомой седалищного нерва;

г) компрессией полового нерва.

59. Сколько слоев мышц можно выделить в ягодичной области?

а) один;

б) два;

в) три;

г) четыре.

60. Какой характер имеют воспалительные процессы в толще большой ягодичной мышцы?

а) ограниченный;

б) разлитой.

61. Какая мышца разделяет большое седалищное отверстие на два отдела?

а) внутренняя запирательная мышца;

б) грушевидная мышца;

в) близнецовые мышцы;

г) наружная запирательная мышца.

62. За счет расщепления какой фасции образован пудендальный канал (канал Алькока)?

а) m. obturatorius externus;

б) m. obturatorius internus;

в) m. Iliopsoas;

г) m. Sartorius.

63. Какой элемент занимает медиальное положение в

подгрушевидном отверстии?

а) седалищный нерв;

б) нижняя ягодичная артерия;

в) задний кожный нерв бедра;

г) половой нерв.

64. Какой элемент занимает латеральное положение в подгрушевидном отверстии?

а) нижняя ягодичная артерия;

б) седалищный нерв;

в) половой нерв;

г) задний кожный нерв бедра.

65. Куда направляется половой нерв после выхода из подгрушевидного отверстия?

а) в седалищно-прямокишечную ямку через малое седалищное отверстие;

б) в запирательный канал;

в) в бедренный канал;

г) в паховый канал.

66. Что составляет содержимое подмышечной полости?

а) подмышечная артерия (a. axillaris) с её ветвями;

б) подмышечная вена (v. axillaris) с её ветвями;

в) подкожная вена руки (v. cephalica);

г) рыхлая жировая клетчатка.

67. Какие сумки и синовиальные влагалища открываются в полость плечевого сустава?

а) межбугорковое синовиальное влагалище (vagina sinovialis intertubercularis);

б) подсухожильная сумка подлопаточной мышцы (bursa subtendinea m. subscapularis);

в) поддельтовидная сумка (bursa subdeltoidea);

г) подсухожильная сумка трапециевидной мышцы (bursa subdeltoidea m.

trapezii).

68. Назовите нервы, расположенные в локтевой ямке:

а) мышечно-кожный нерв (n. musculocutaneus);

б) лучевой нерв (n. radialis);

в) локтевой нерв (п. ulnaris);

г) срединный нерв (n. medianus).

69. Укажите образования, проходящие через канал запястья (canalis carpalis):

а) локтевой нерв (п. ulnaris);

б) лучевой нерв (n. radialis);

в) срединный нерв (n. medianus);

г) сухожилия поверхностного и глубокого сгибателей пальцев.

70. Назовите ветви глубокой ладонной дуги (arcus palmaris profundus):

а) общие ладонные пальцевые артерии (aa. digitales palmares communes);

б) собственные пальцевые артерии (aa. digitales palmares propriae);

в) локтевая артерия (a. ulnaris);

г) ладонные пястные артерии (aa. metacarpeae palmares).

71. Укажите ветви первого отрезка подмышечной артерии (a. axillaris):

а) внутренняя грудная артерия (a. thoracica interna);

б) латеральная грудная артерия (a. thoracica lateralis);

в) верхняя грудная артерия (a. thoracica superior);

г) грудоакромиальная артерия (a. thoracoacromialis).

72. Где расположен мышечно-кожный нерв (n. musculocutaneus) в нижней трети плеча?

а) между сухожилием двуглавой мышцы плеча (т. biceps brachii) и клювовидно-плечевой мышцей (т. coracobrachialis);

б) между двуглавой мышцей плеча (т. biceps brachii) и плечевой мышцей

(т. brachialis);

в) кнутри от плечевой артерии (a. brachialis);

г) у медиального края межмышечной щели.

73. Укажите элементы основного сосудисто-нервного пучка в ключично-грудном треугольнике (trigonum clavipectorale):

а) стволы плечевого сплетения (plexus brachialis);

б) медиальная подкожная вена руки (v. basilica) и медиальный кожный нерв предплечья (taneus antebrachii medialis);

в) подмышечная вена (v. axillaris);

г) подмышечная артерия (a. axillaris).

74. Укажите элементы основного сосудисто-нервного пучка в подгрудном треугольнике (trigonum subpectorale):

а) срединный нерв (п. medianus);

б) латеральная подкожная вена руки {v. cephalica);

в) мышечно-кожный нерв (n. muscutaneus);

г) подмышечная вена (v. axillaris).

75. Укажите конечные ветви поверхностного берцового нерва (n. peroneus superficialis):

а) медиальный тыльный кожный нерв (п. cutaneus dorsalis medialis);

б) промежуточный тыльный кожный нерв (n. cutaneus dorsalis intermedius);

в) латеральный тыльный кожный нерв (n. cutaneus dorsalis altateralis);

г) подкожный нерв (п. saphenus).

76. Чем сформировано подгрушевидное отверстие?

а) большой ягодичной мышцей (т. gluteus maximus);

б) средней ягодичной мышцей (m. gluteus medius);

в) крестцово-остистой связкой (lig. sacrospinale);

г) грушевидной мышцей (т. piriformis).

77. Чем образована медиальная стенка сосудистой лакуны (lacuna vasorum)?

а) бедренной веной (v. femoralis);

б) верхней лобковой связкой (lig. pubicum superius);

в) лакунарной связкой (lig. lacunare);

г) Подвздошно-гребенчатой дугой (arcus iliopectineus).

78. Какие мышцы образуют дно бедренного треугольника?

а) гребенчатая мышца (т. pectineus);

б) короткая приводящая мышца (т. adductor brevis);

в) длинная приводящая мышца (т. adductor longus);

г) пояснично-подвздошная мышца (m. iliopsoas).

79. Какие ветви отдаёт дорсальная артерия стопы (a. dorsalis pedis)?

а) первую тыльную плюсневую артерию (a. metatarsea dorsalis prima);

б) тыльные плюсневые артерии (aa. metatarseae dorsales);

в) дугообразную артерию (a. arcuata);

г) глубокую подошвенную ветвь (r. plantaris profundus).

80. Что проходит через нижнее отверстие приводящего канала?

а) бедренная артерия (a. femoralis);

б) бедренная вена (v. femoralis);

в) подкожный нерв (п. saphenus);

г) седалищный нерв (n. ischiadicus).

81. Какие связки укрепляют капсулу тазобедренного сустава?

а) круговая зона (zona orbicularis);

б) седалищно-бедренная связка (lig. ischiofemoralis);

в) связка головки бедра (lig. capitis femoris);

г) подвздошно-бедренная связка (lig. iliofemorale).

82. Что проходит в пяточном канале (canalis calcaneus)?

а) медиальные и латеральные подошвенные артерии и вены;

б) сухожилие длинного сгибателя большого пальца;

в) сухожилие задней большеберцовой мышцы;

г) сухожилие длинного сгибателя пальцев.

83. Чем образованы стенки запирательного канала?

а) запирательным отверстием;

б) запирательной бороздой лобковой кости;

в) запирательной мембраной;

г) внутренней запирательной мышцей.

84. Какие образования принимают участие в формировании

коленного сустава?

а) суставная поверхность медиального мыщелка бедренной кости;

б) головка малоберцовой кости;

в) суставная поверхность надколенника;

г) суставная поверхность латерального мыщелка большеберцовой кости.

85. Какие связки укрепляют коленный сустав сзади?

а) передняя и задняя крестовидные связки;

б) косая подколенная связка;

в) большеберцовая коллатеральная связка;

г) дугообразная подколенная связка.

86. Между какими образованиями расположен общий малоберцовый

нерв (n. peroneus communis)?

а) короткой малоберцовой мышцей;

б) передней межмышечной перегородкой;

в) шейкой малоберцовой кости;

г) двумя головками длинной малоберцовой мышцы.

87. Какие нервы расположены в подколенной ямке?

а) большеберцовый нерв;

б) бедренный нерв;

в) латеральный кожный нерв бедра;

г) общий малоберцовый нерв.

88. Какие образования принимают участие в формировании верхнего

мышечно-малоберцового канала?

а) длинная малоберцовая мышца;

б) короткая малоберцовая мышца;

в) большеберцовая кость;

г) малоберцовая кость.

89. Между какими образованиями расположен глубокий

малоберцовый нерв (n. peroneus profundus) в верхней трети голени?

а) межкостной мембраной;

б) передней большеберцовой мышцей;

в) длинным разгибателем пальцев;

г) длинным разгибателем большого пальца.

90. Какие образования принимают участие в формированни стенок голеноподколенного канала?

а) задняя большеберцовая мышца;

б) глубокий листок фасции голени;

в) длинный сгибатель пальцев;

г) камбаловидная мышца.

91. Что проходит в расщеплении поверхностной пластинкн фасции голени и средней трети задней поверхности голени?

а) глубокий малоберцовый нерв;

б) большая подкожная вена;

в) малая подкожная вена;

г) подкожный нерв.

92. Между какими образованиями проходят латеральные подошвенные сосуды и нерв?

а) длинным сгибателем пальцев;

б) коротким сгибателем пальцев;

в) квадратной мышцей подошвы;

г) латеральной фасциальной межмышечной перегородкой.

93. Что проходит через запирательный канал?

а) запирательный нерв;

б) запирательная артерия;

в) запирательная вена;

г) внутренняя запирательная артерия.

94. Какие образования принимают участие в формировании бедренного треугольника?

а) лакунарная связка;

б) портняжная мышца;

в) длинная приводящая мышца;

г) паховая связка.

95. Чем образована медиальная стенка мышечной лакуны ?

а) бедренной веной;

б) лобковой связкой;

в) лакунарной связкой;

г) подвздошно-гребенчатой дугой.

96. Какие ветви отходят от бедренной артерии в бедренном треугольнике?

а) глубокая артерия бедра;

б) поверхностная надчревная артерия;

в) поверхностная артерия, огибающая подвздошвенную кость;

г) наружные половые артерии.

Тема № 8

Операции на сосудах, нервах, сухожилиях, костях суставах конечностей. Усечения конечностей

1. Что подразумевается под термином «перевязка артерии на протяжении»?

а) лигирование артерии на расстоянии 2-3 см ниже от места ее поврежде ния;

б) перевязка артерии в проксимальном отделе конечности;

в) перевязка артерии вне раны в пределах здоровых тканей проксимальнее повреждения;

г) перевязка артерии вместе с веной.

2. Что такое «прямой доступ к артерии»?

а) прямолинейный разрез;

б) разрез, ориентированный по продольной оси конечности;

в) доступ строго по проекционной линии артерии;

г) доступ вне проекционной линии.

3. Что такое «окольный доступ» к артерии?

а) доступ поперек хода сосудисто-нервного пучка;

б) доступ, связанный с необходимостью раздвигания мышц;

в) доступ вне проекционной линии;

г) доступ, связанный с необходимостью рассечения мышц.

4. В каких случаях производится перевязка артерии на протяжении?

а) при некрозе дистального отдела конечности;

б) при кровотечении из гнойной раны;

в) при кровотечении из размозженной раны;

г) при кровотечении из раны, расположенной в области со сложными

топографо-анатомическими взаимоотношениями.

5. Что такое коллатеральное кровообращение?

а) уменьшенное кровообращение в конечности после одновременной

перевязки артерии и вены;

б) кровоток по боковым ветвям после прекращения движения крови по

магистральному сосуду;

в) движение крови в восходящем направлении;

г) восстановленное кровообращение в конечности.

6. Какие виды анастомозов выделяют при формировании

коллатерального кровообращения?

а) околосистемные анастомозы;

б) межсистемные анастомозы;

в) внутрисистемные анастомозы;

г) системные анастомозы.

7. Какой наиболее распространенный способ улучшения

коллатерального кровообращения?

а) параартериальное введение новокаина;

б) пересечение стенки артерии между двумя лигатурами для снятия спа

стического действия вазоконстрикторов;

в) региональная гемоперфузия;

г) массаж.

8. Как проводится проекционная линия лучевой артерии?

а) от середины локтевой ямки к шиловидному отростку локтевой кости;

б) от середины локтевой ямки к внутреннему краю шиловидного отростка лучевой кости;

в) от медиального надмыщелка плечевой кости к гороховидной кости;

г) от середины локтевой ямки к гороховидной кости.

9. Как проводится проекционная линия плечевой артерии?

а) от вершины подмышечной впадины к середине расстояния между внутренним надмыщелком плечевой кости и сухожилием двуглавой мышцы плеча;

б) от клювовидного отростка лопатки к медиальному надмыщелку плеча;

в) от акромиона к медиальному надмыщелку плечевой кости;

г) все ранее указанные линии верны.

10. Как проводится проекционная линия подмышечной артерии?

а) по переднему краю роста волос;

б) на границе передней и средней третей ширины подмышечной впадины;

в) от клювовидного отростка лопатки вниз;

г) вниз от акромиона.

11. Какой доступ производится к лучевой артерии в нижней трети предплечья?

а) прямой;

б) окольный.

12. Между сухожилиями каких мышц следует искать лучевую артерию в нижней трети предплечья?

а) m. flexor carpi radialis и m. Brachioradialis;

б) m.flexor carpi radialis и m.palmans longus;

в) m.flexor digitorum superficialis и profundus;

г) m.flexor carpi radialis и ulnaris.

13. С какой стороны следует подводить лигатурную иглу при перевязке локтевой артерии?

а) со стороны локтевого нерва;

б) с латеральной стороны;

в) с любой стороны;

г) ≪от себя≫.

14. Какой доступ используется при обнажении плечевой артерии в средней трети плеча?

а) прямой;

б) окольный.

15. На каком уровне целесообразно накладывать лигатуры на плечевую артерию для лучшего функционирования коллатералей?

а) на любом уровне;

б) выше уровня отхождения глубокой артерии плеча;

в) ниже уровня отхождения глубокой артерии плеча;

г) в нижней трети плеча.

16. На каком уровне следует накладывать лигатуры, на подмышечную артерию?

а) на любом уровне;

б) выше уровня отхождения a. Subscapularis;

в) ниже уровня отхождения a. subscapularis;

г) на уровне нижнего края большой грудной мышцы.

17. Как проводится проекционная линия задней большеберцовой артерии?

а) от медиального надмыщелка бедренной кости к медиальной лодыжке;

б) от середины подколенной ямки к середине расстояния между медиаль ной лодыжкой и ахилловым сухожилием;

в) от середины подколенной ямки к пяточному бугру;

г) от бугристости большеберцовой кости к наружной лодыжке.

18. На каком уровне целесообразнее накладывать лигатуры на бедренную артерию при ее перевязке в верхней трети бедра?

а) на любом;

б) выше уровня отхождения глубокой артерии бедра;

в) ниже уровня отхождения глубокой артерии бедра;

г) на 1 см ниже паховой связки.

19. Какая артерия сопровождает лучевой нерв на плече?

а) глубокая артерия плеча;

б) плечевая артерия;

в) a. collateralis ulnaris superior;

г) a. collateralis radialis.

20. Чем опасно прохождение лучевого нерва рядом с «хирургической шейкой» плечевой кости?

а) возможностью ущемления нерва при переломах плечевой кости;

б) возможностью врастания нерва в костную мозоль;

в) возможностью разрыва нерва;

г) возможностью развития всех перечисленных явлений.

21. Какие мышцы прикрывают сзади седалищный нерв на бедре?

а) длинная головка двуглавой мышцы бедра;

б) полусухожильная мышца;

в) внутренняя близнецовая;

г) полуперепончатая мышца.

22. С какой скоростью обычно происходит регенерация аксонов центрального конца периферического нерва после повреждения?

а) 1-1,5 мм в сутки;

б) 2-3 мм в сутки;

в) 5-10 мм в сутки;

г) 11-15 мм в сутки.

23. Какие доступы используются при обнажении нервов?

а) только прямые;

б) только окольные;

в) прямые доступы к глубокорасположенным нервам;

г) окольные доступы к поверхностным нервам.

24. Что такое «неврома»?

а) доброкачественная опухоль нерва;

б) утолщение из нервных отростков и их оболочек, образующееся на цен

тральном конце нерва после полного его разрыва;

в) жгучие, невыносимые боли в дистальном отделе конечности при

повреждении нерва;

г) фантомные боли после ампутации.

25. Какие оболочки нерва обычно включают в шов при соединении

концов нерва?

а) эндометрий;

б) периневрий;

в) эпиневрий;

г) эндотелий.

26. Что такое «тенотомия»?

а) соединение концов поврежденного сухожилия;

б) пересечение сухожилия закрытым или открытым методом;

в) удлинение сухожилия;

г) пересадка сухожилия.

27. Какие требования предъявляются к сухожильному шву?

а) захватывание минимального количества сухожильных пучков;

б) обеспечение гладкой поверхности сухожилий;

в) недопущение разволокнения концов сухожилия;

г) сохранение сосудов и кровоснабжения сухожилия.

28. Где чаще происходит разрыв капсулы плечевого сустава при

гнойном омартрите?

а) в надмышечном завороте;

б) в подмышечном завороте;

в) в подлопаточном завороте;

г) в межбугорковом завороте.

29. Где находится передняя точка для прокола плечевого сустава?

а) под акромионом;

б) под клювовидным отростком;

в) в межбугорковой борозде;

г) по середине переднего края дельтовидной мышцы.

30. Ветви какого нерва могут быть повреждены при проведении артротомии заднего отдела плечевого сустава?

а) срединного нерва;

б) лучевого нерва;

в) локтевого нерва;

г) подмышечного нерва.

31. Где находится «слабое место» локтевого сустава?

а) в районе лучелоктевого сустава;

б) в задневерхнем отделе капсулы;

в) в передневерхнем отделе капсулы;

г) в переднем отделе капсулы.

32. Где находится точка пункции тазобедренного сустава?

а) по середине длины паховой связки;

б) на середине длины линии, соединяющей границу между внутренней и средней третью паховой связки с большим вертелом бедренной кости;

в) над большим вертелом;

г) по середине ягодичной складки.

33. Где чаще всего производится пункция коленного сустава?

а) у бугристости большеберцовой кости;

б) со стороны подколенной ямки;

в) у латерального края надколенника;

г) у медиального края надколенника.

34. Что такое «артротомия»?

а) вскрытие полости сустава;

б) удаление суставных поверхностей при их повреждении;

в) удаление периферической части конечности на уровне сустава;

г) введение в сустав дренажей.

35. Что означает термин «ампутация конечности»?

а) удаление периферической части конечности на протяжении кости;

б) удаление части конечности на уровне сустава;

в) удаление конечности в проксимальном отделе;

г) рассечение мягких тканей конечности.

36. Какие показания к ампутации конечности относятся к абсолютным?

а) газовая гангрена;

б) острое гнойное воспаление, угрожающее переходом в септическую фазу;

в) ожоги и отморожения 3-4 степени;

г) открытое повреждение конечности, при котором сочетаются полный разрыв сосудисто-нервных пучков, раздробление кости и разрушение более 2/3 объема мягких тканей.

37. Какие этапы ампутации конечности Вы знаете?

а) рассечение мягких тканей;

б) наложение жгута;

в) обработка надкостницы и перепил кости;

г) туалет или обработка культи.

38. Какие виды ампутаций Вы знаете?

а) круговые;

б) поперечные;

в) лоскутные;

г) полные.

39. Какие виды круговых ампутаций Вам известны?

а) одномоментная;

б) двухмоментная;

в) трехмоментная;

г) четырехмоментная.

40. Как подразделяются лоскутные ампутации в зависимости от количества лоскутов?

а) однолоскутные;

б) двулоскутные;

в) трехлоскутные;

г) четырехлоскутные.

41. В зависимости от состава лоскутов какие бывают ампутации?

а) фасциально-пластические;

б) мио-пластические;

в) костно-пластические;

г) аллопластические.

42. Какие методы используют для предупреждения кровотечения при проведении ампутации?

а) пальцевое прижатие артерии;

б) тугое бинтование конечности выше ампутации;

в) наложение жгута;

г) перевязку артерии на протяжении.

43. Что такое «уровень ампутации»?

а) место рассечения мягких тканей;

б) место наибольшего разрушения мягких тканей;

в) место перепила кости;

г) место пересечения нервов.

44. Как находят крупные сосуды для лигирования при туалете культи?

а) на основании топографо-анатомических ориентиров;

б) по кровотечению после снятия жгута;

в) по пульсации артерии;

г) используя проекционные линии.

45. Для чего усекают концы нервов при ампутации?

а) для предотвращения развития невромы;

б) для предотвращения развития фантомных болей;

в) для предупреждения развития каузалгий;

г) для того, чтобы сформировалась неврома небольших размеров.

46. На каком расстоянии от уровня ампутации усекают концы нервов при ампутации конечности?

а) 1 см;

б) 3 см;

в) 5-6 см;

г) 8 см.

47. С помощью каких приспособлений оттягиваются мягкие ткани

в проксимальном направлении после рассечения мышц при ампутации?

а) с помощью марлевого ретрактора;

б) с помощью крючков Фарабефа;

в) с помощью металлического ретрактора;

г) с помощью лопатки Буяльского.

48. Какие инструменты используются для выравнивания краев опила

кости?

а) рашпиль;

б) кусачки Люэра;

в) кусачки Листона;

г) кусачки Дальгрена.

49. Какие виды протезов верхней конечности Вы знаете?

а) косметический;

б) рабочий;

в) тягово-мышечный;

г) биоэлектрический.

50. С помощью какого инструмента должно производиться усечение

конца нерва при ампутации конечности?

а) лазерного скальпеля;

б) ножниц;

в) лезвия бритвы;

г) электроножа.

51. В чем заключается преимущество костно-пластической

ампутации конечности перед другими видами ампутаций?

а) в технической простоте;

б) в создании опороспособной культи;

в) в незначительном уменьшении длины части конечности;

г) в возможности использования ортопедической обуви вместо протеза.

52. Какая кость включается в состав лоскута при

костнопластической ампутации бедра по Гритти—Шимановскому—

Альбрехту?

а) пяточная;

б) бугристость большеберцовой кости;

в) надколенник;

г) фрагмент бедренной кости.

53. Какие ткани рассекаются круговым разрезом при выполнении

первого момента конусо-круговой ампутации по Н. И. Пирогову?

а) все мягкие ткани;

б) кожа;

в) кожа и подкожная клетчатка;

г) кожа, подкожная клетчатка, поверхностная и собственная фасции.

54. Какие недостатки трехмоментной конусо-круговой ампутации

Вы знаете?

а) трудоемкость;

б) формирование послеоперационного рубца на рабочей поверхности

культи;

в) неэкономность;

г) формирование порочной культи.

55. Какие ампутации чаще применяются в мирное время?

а) круговые;

б) лоскутные;

в) костно-пластические;

г) ампутации с манжеткой.

56. Какие требования применяют к сосудистому шву ?

а) герметичность;

б) прочность;

в) отсутствие сужения по линии шва;

г) соприкосновение по линии шва только внутренних (интимы) оболочек

сосуда.

57. Какие бывают способы тромбэмболэктомии ?

а) прямая;

б) закрытая;

в) открытая;

г) непрямая.

58. Как классифицируются сосудистые швы ?

а) боковые;

б) циркулярные;

в) ручные;

г) вторичные.

59. Укажите способы временной остановки кровотечения?

а) пальцевое прижатие;

б) перевязка сосуда в ране;

в) перевязка сосуда на протяжении;

г) наложение жгута.

60. В чем заключается принцип операции шунтирования сосудов?

а) замена пораженного участка сосуда протезом;

б) удаление тромба или эмбола из сосуда;

в) создание обходного пути для кровотока;

г) наложение бокового и циркулярного сосудистого шва.

61. По каким показаниям выполняется остеотомия?

а) открытые переломы;

б) врожденная и приобретенная деформация костей;

в) неправильные анкилозы;

г) укорочение конечности.

62. Какие Вы знаете способы металлоостеосинтеза ?

а) экстрамедуллярный;

б) интрамедуллярный;

в) трансперистальный;

г) дистракционный.

63. Какие оперативные доступы чаще всего применяют при

артротомии коленного сустава?

а) парапателлярные разрезы;

б) разрез над сухожилием двуглавой мышцы бедра;

в) разрез через подколенную ямку;

г) разрез между полусухожильной и полуперепончатой мышцами.

64. Какой оперативный доступ чаше всего используют при

артротомии голеностопного сустава?

а) передний;

б) задний;

в) медиальный;

г) латеральный.

65. Что служит показанием к выполнению резекции сустава?

а) определение характера содержимого сустава;

б) удаление инородных тел;

в) проведение асептических операций внутри сустава;

г) гнойные воспаления сустава с разрушением эпифизов.

66.К какому виду относится ампутация голени по Пирогову?

а) конусно-круговая;

б) лоскутная;

в) костно-пластическая;

г) двухмоментная круговая.

67. Какие оперативные доступы чаще всего применяют при

артротомии тазобедренного сустава?

а) задний;

б) комбинированный;

в) латеральный;

г) медиальный.

68. Какие разрезы применяют для вскрытия флегмон стопы?

а) медиальный разрез по краю свода стопы;

б) латеральный разрез по краю свода стопы;

в) срединный разрез;

г) разрезы по медиальной и латеральной апоневротическим перегородкам.

69. Как обрабатывают кость и надкостницу при ампутации?

а) поверхность опила должна быть расположена поперечно оси конечности;

б) костный мозг вычерпывают;

в) надкостницу сдвигают вниз;

г) надкостницу циркулярно рассекают выше предполагаемого уровня ампутации.

70. Как обрабатывают сосуды при ампутации?

а) сосуды перевязывают после распускания жгута;

б) сосуды перевязывают перед распусканием жгута;

в) артерию и вену перевязывают вместе;

г) на крупные сосуды накладывают лигатуру с прошиванием.

71. Выберите определение реампутации:

а) вторая по счёту ампутация;

б) ампутация, выполненная через 48 ч;

в) ампутация, выполненная в течение 7—8 дней;

г) повторная ампутация.

72. На что направлен остеосинтез?

а) на создание идеального сопоставления костных отломков;

б) на исправление дефектов кости;

в) на ручное сопоставление костных отломков;

г) на замещение дефектов кости.

73. На что направлена остеотомия?

а) на создание анкилоза;

б) на закрытие дефекта кости;

в) на совмещение костных отломков;

г) на исправление деформаций длинных трубчатых костей.

74. Какие виды остеотомии Вы знаете?

а) клиновидная;

б) сферическая;

в) угловая;

г) сегментарная.

75. Чем отличается сосудистый шов по Морозовой от шва по Каррелю?

а) на сосуды накладывают п-образный шов;

б) сближение сосудов производят двумя швами-держалками;

в) интервал между стежками составляет 3 мм;

г) применяют инвагинационные швы.

76. На что направлен артрориз?

а) на создание анкилоза сустава;

б) на создание условий, ограничивающих подвижность сустава;

в) на создание условий, восстанавливающих подвижность сустава;

г) на сопоставление костных отломков.

77. Где пунктируют плечевой сустав?

а) под клювовидным отростком;

б) латерально от клювовидного отростка;

в) в ямке между задним краем дельтовидной мышцы и краем надостной мышцы;

г) под задним краем акромиального отростка.

78. Каковы основные требования, предъявляемые к сосудистым швам?

а) соединение сосудов нужно производить с минимальным сужением просвета;

б) концы сосудов должны соприкасаться своими внутренними поверхно стями;

в) концы сосудов должны сшиваться конец в конец;

г) обязательна герметичность анастомоза.

79. Укажите основные этапы секвестрэктомии:

а) остеотомия;

б) удаление грануляционной ткани;

в) рассечение кости и надкостницы;

г) пломбирование или замещение полости пластическим материалом.

80. Как проводят разрезы при флегмонах поддельтовидного клетчаточного пространства?

а) по переднему краю дельтовидной мышцы;

б) по заднему краю дельтовидной мышцы;

в) через дельтовидную мышцу ближе к её переднему краю;

г) по дельтовидно-грудной борозде.

81. Как выполняют удаление варикозно расширенных вен по Маделунгу?

а) разрезом по медиальной поверхности бедра;

б) разрезом по медиальной поверхности голени;

в) двумя небольшими разрезами по ходу большой подкожной вены;

г) разрезом по ходу большой подкожной вены до уровня внутреннего надмыщелка бедра.

82. Назовите цели венесекции:

а) прокол вены;

б) диагностика компонентов крови;

в) внутривенное вливание жидкости;

г) доступ в вену при затруднении венепункции.

83. Назовите основные этапы венесекции:

а) дезинфекция кожи;

б) разрез кожи;

в) рассечение вены на 1/2 её диаметра;

г) полное рассечение вены по диаметру.

Тема № 9

Эндоскопическая хирургия. Трансплантация органов

1. К недостаткам эндоскопической хирургии перед традиционной относятся следующие:

а) снижение стоимости лечения;

б) эффект качелей;

в) пальпация органов возможна только с помощью инструментов;

г) снижение продолжительности нахождения в стационаре.

2. К преимуществам эндоскопической хирургии перед традиционной относятся:

а) снижение травматичности операций;

б) снижение частоты интраоперационных осложнений;

в) сокращение срока утраты трудоспособности;

г) хороший косметический эффект.

3. В каком году выполнена первая лапароскопическая аппендэктомия?

а) 1963 г;

б) 1983 г;

в) 1993 г;

г) 2003 г.

4. К оборудованию, используемому для проведения эндоскопических операций, относятся:

а) инсуффлятор;

б) ранорасширитель;

в) видеокамера;

г) электрохирургический аппарат.

5. Все эндохирургические инструменты по назначению могут быть разделены на следующие группы:

а) инструменты для соединения тканей;

б) кровоостанавливающие инструменты;

в) инструменты доступа;

г) инструменты для манипуляций.

6. Как называется инструмент для наложения механического ниточного шва?

а) троакар;

б) эндостич;

в) клипатор;

г) степлер.

7. Как называется введение в брюшную полость газа для создания необходимого рабочего пространства при лапароскопической операции?

а) пневмоторакс;

б) пневмомедиастинум;

в) пневмоперитонеум;

г) гидроперитонеум.

8. Какой газ может использоваться для создания пневмоперитонеума?

а) углекислый;

б) закись азота;

в) воздух;

г) кислород.

9. За счет каких действий достигается фиксация тканей для их безопасной препаровки, рассечения и ушивания при эндохирургической операции?

а) тракции и противотракции;

б) сгибания и разгибания;

в) приведения и отведения;

г) пронации и супинации.

10. Какие способы соединения тканей в эндохирургии не сопровождаются завязыванием узлов?

а) ручной ниточный шов;

б) механический ниточный шов;

в) наложение клипс;

г) использование сшивающих аппаратов.

11. Какие Вы знаете приемы, разработанные для извлечения удаляемых тканей при лапароскопической операции?

а) задняя кольпотомия;

б) срединная лапаротомия;

в) использование контейнера;

г) использование морцеллятора.

12. В каких случаях осуществляется переход с лапароскопической техники операции на традиционную (конверсия)?

а) при нехватке времени;

б) при выраженной воспалительной инфильтрации;

в) при выходе из строя эндохирургического оборудования;

г) при недостатке опыта.

13. В какой точке вводят троакар для лапароскопа при типичной лапароскопической холецистэктомии?

а) под мечевидным отростком;

б) слева по среднеключичной линии ниже реберной дуги;

в) ниже пупка по белой линии;

г) справа по передней подмышечной линии на уровне пупка.

14. Как обрабатывают основание аппендикса при лапароскопической аппендэктомии?

а) пересекают между двумя лигатурами;

б) погружают культю в кисетный шов;

в) коагулируют слизистую культи отростка;

г) накладывают Z–образный шов на купол слепой кишки.

15. Из каких доступов может быть выполнена лапароскопическая герниопластика?

а) только из интраперитонеального;

б) только из экстраперитонеального;

в) из интраперитонеального или экстраперитонеального;

г) из промежностного.

16. Какую стенку пахового канала укрепляют при лапароскопической герниопластике?

а) переднюю;

б) заднюю;

в) верхнюю;

г) нижнюю.

17. Для какой области хирургии изначально была разработана лапароскопическая техника операций?

а) для торакальной хирургии;

б) для хирургии желудка;

в) для хирургии желчного пузыря;

г) для оперативной гинекологии.

18. В каком положении на операционном столе находится пациентка при лапароскопической гинекологической операции?

а) в положении Тренделенбурга;

б) с приподнятым головным концом операционного стола;

в) в строго горизонтальном положении.

19. Наибольшую опасность при лапароскопической технике ампутации матки представляют осложнения:

а) повреждение брыжейки тонкой кишки;

б) повреждение мочеточника;

в) повреждение мочевого пузыря;

г) повреждение наружной подвздошной вены.

20. В какой стране выполнена первая успешная пересадка сердца человеку?

а) США;

б) Великобритания;

в) ЮАР;

г) Франция.

21. Как называется пересадка реципиенту органа от донора того же биологического вида?

а) аутотрансплантация;

б) аллотрансплантация;

в) ксенотрансплантация;

г) реплантация.

22. Какие Вы знаете основные проблемы аллотрансплантации

органов?

а) иммунные;

б) технические;

в) донорства и консервации органов;

г) психологические.

23. Какие Вы знаете пути преодоления реакции отторжения органа при трансплантации?

а) тщательное соблюдение технологии пересадки;

б) подбор донора;

в) предупреждение гнойных осложнений;

г) иммуносупрессия.

24. Как долго пациенты с пересаженными органами должны принимать иммунодепрессанты?

а) 2–3 недели;

б) 6 месяцев;

в) пожизненно;

г) 3–4 года.

25. Кто является идеальным донором органов для пересадки?

а) мать;

б) отец;

в) брат;

г) однояйцевый близнец.

26. Какие Вы знаете методы борьбы с ишемическим повреждением донорских органов?

а) содержание в гипертоническом растворе;

б) биологическая перфузия;

в) гипотермическая консервация;

г) замораживание.

27. Назовите основные критерии диагноза смерти мозга:

а) кома с утратой сознания;

б) афония;

в) апноэ;

г) отсутствие рефлексов.

28. Какие процедуры являются альтернативой пересадке почки при ХПН?

а) перитональный диализ;

б) гемодиализ;

в) иммуносупрессия;

г) нефростома.

29. Чем должны руководствоваться врачи при заборе органов для пересадки в Республике Беларусь?

а) презумпцией несогласия;

б) презумпцией невиновности;

в) презумпцией согласия;

г) указаниями главврача.

30. Как называется пересадка донорского органа в типичную анатомическую позицию?

а) гетеротопическая;

б) ортотопическая;

в) аллогенная;

г) гетерогенная.